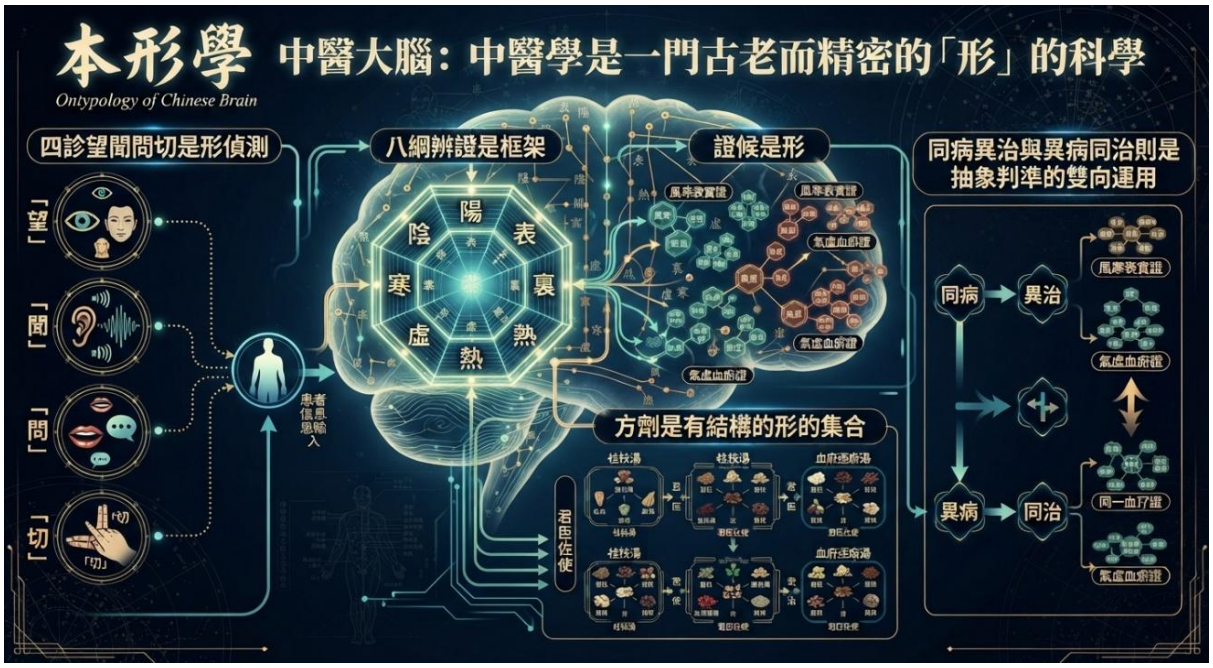


AI 中醫大腦系統

Mind AI 平台 × 本形學 Ontypology

形驅動辨證論治 Type-Driven Diagnosis & Treatment

全科涵蓋 | 四診・辨證・本草・方劑・針灸・養生・專科・經典

前　言

《AI 中醫大腦系統．準確使用方法完全方案》是「準確使用方法」系列在中醫領域的完全方案書：以本形學（空間本形與時間本形）為理論基礎、以 Mind AI 為平台底座，給出一套把中醫全科知識形化、並以受檢核的推理流程完成辨證論治的完整方法。

本書的三個關鍵詞是「形 Type」「判準」「留痕」：一切中醫知識皆以形（Type）存在；一切結論皆須通過交集判準 ∩(T) 檢核；一切推理皆入形證據鏈。圍繞這三個關鍵詞，全書分為八章：第 1 章立系統定位與雙本形運用總綱；第 2–3 章展開空間本形的知識形化工程與時間本形的動態推理；第 4 章鋪陳中醫全科知識映射；第 5 章建立形驅動辨證論治八步驟；第 6 章是核心的 S1–S8 準確使用方法提示詞手冊；第 7 章立準確性保證與醫療安全護欄；第 8 章附速查附錄。

依文件定位，本形學與 Mind AI 平台本身的理論內容不在書中重述，一切環節直接以該理論的術語與操作體系運用於中醫；「形」之英文譯名一律用 Type。本書為方案書，不含系統實作。

鄭重聲明：本書所述系統為醫療輔助工具，不能替代執業中醫師的診斷與處方。任何診療決策皆須經執業中醫師覆核簽署；急危重症請即刻就近就醫，不得以本書內容延誤救治。

目　錄

第 1 章 系統定位與雙本形運用總綱 6

1.1 系統定位與願景 6

1.2 空間本形之運用總綱 7

1.3 時間本形之運用總綱 8

1.4 形驅動辨證論治：TDDT 方法論 9

1.5 四層準確性保證 10

1.6 系統總覽架構 11

1.7 文件導讀 12

第 2 章 中醫知識形化工程 — 空間本形全面應用 14

2.1 中醫形分類體系：十四形總表 14

2.2 屬性．屬性值設計準則 16

2.3 空間容器與形集合三括號之運用 18

2.4 BOM / SOM 雙向對應 19

2.5 框架四步驟之操作規範 20

2.6 RDB 對應原則：表頭即形 22

2.7 交集判準 ∩(T) 之形式化 22

2.8 形化品質檢核清單 24

第 3 章 時間本形於中醫動態推理 25

3.1 病程時間軸與傳變形 25

3.2 三大傳變體系的時間結構 26

3.3 四診動態採集與時間序列 26

3.4 治療時間軸：服藥時辰．子午流注．療程節點 27

3.5 時間本形四模式之臨床循環 29

3.6 自我演化：療效回饋與判準精進 30

第 4 章 中醫全科知識映射 — 九大知識域 31

4.1 中醫基礎理論形化 31

4.2 中醫診斷學：四診全項形化 34

4.3 辨證體系大全 38

4.4 中藥學：本草形的完整屬性空間 41

4.5 方劑學：方劑形的組成學 45

4.6 針灸經絡學 48

4.7 養生治未病：體質形與養生形 51

4.8 專科知識：專科形的臨床覆蓋 53

4.9 經典典籍：典籍形的知識源流 56

第 5 章 形驅動辨證論治八步驟 TDDT 60

5.1 TDDT 總覽與步驟銜接 60

5.2 T1–T8 步驟規範 61

5.3 全程留痕與形證據鏈 62

第 6 章 準確使用方法提示詞手冊 S1–S8 63

6.0 使用方法總則 63

6.1 S1 四診採集官 — 資訊形化 65

6.2 S2 八綱定位官 — 病位病性初判 67

6.3 S3 辨證推理官 — 體系推演 69

6.4 S4 治則確立法官 — 治法推導 71

6.5 S5 方藥設計官 — 君臣佐使 72

6.6 S6 針灸外治官 — 經穴處方 74

6.7 S7 療效演化官 — 病程評估 76

6.8 S8 知識沉澱官 — 醫案演化 78

6.9 綜合醫案演練：一案走完 S1–S8 79

6.10 提示詞使用要點與常見偏差 81

6.11 第二演練：風熱咳嗽案的雙工作流對話實錄 82

第 7 章 準確性保證與醫療安全 84

7.1 四層準確性保證的執行規範 84

7.2 形證據鏈與可審計性 85

7.3 醫療安全護欄 86

7.4 用藥安全檢核清單 86

7.5 危急重症識別與轉診警訊 87

7.6 不確定性管理與人工覆核 88

7.7 醫療文書、倫理與個資規範 88

7.8 中西醫結合使用注意事項 89

第 8 章 附錄 90

8.1 附錄 A：中醫形名詞對照表 90

8.2 附錄 B：常用方劑速查表 91

8.3 附錄 C：常用本草速查表 96

8.4 附錄 D：常用穴位速查表 99

8.5 附錄 E：診療歌訣摘編 101

8.6 附錄 F：S1–S8 提示詞速查總表 102

8.7 附錄 G：核心術語英中對照索引 103

8.8 附錄 H：常見病治法方藥總表 104

第 1 章　系統定位與雙本形運用總綱

AI 中醫大腦系統是一套以 Mind AI 為平台底座、以本形學（空間本形與時間本形）為理論基礎的中醫智慧輔助系統。它不重造中醫理論，而是把中醫兩千年沉澱的知識——從《黃帝內經》的藏象經絡，到《傷寒論》的六經辨證，再到溫病學派的衛氣營血——全部「形化（Type-Izations）」為可檢核、可推演、可回溯的結構，使辨證論治從個人經驗的暗箱，轉變為每一步皆有據可查的透明推理鏈。

本章說明系統的定位、雙本形於中醫的運用總綱、形驅動辨證論治方法論，以及貫穿全書的四層準確性保證。依文件定位，本形學與 Mind AI 平台本身的理論內容不在本書重述；書中一切環節皆直接以該理論之術語與操作體系運用於中醫領域。

1.1　系統定位與願景

◆ 使命：讓辨證論治的每一步皆可形化、可檢核、可回溯

中醫臨床的核心能力是「辨證論治」——透過四診採集資訊，判斷病因病位病性，確立證型，再依治則治法組方用藥、施針取穴。這條鏈條長期依賴醫師個人的心法傳承：同一患者，不同醫師可能辨出不同證型；同一證型，用方思路也各有師承。AI 中醫大腦的定位不是取代醫師，而是把這條推理鏈的每一環節「形化」——賦予明確的形（Type）結構、屬性邊界與判準，使推理可檢核、可比較、可累積。

在 Mind AI 平台之上，大語言模型負責對海量醫案、本草、方劑文獻作歸納統計，Mind Model 則承擔演繹推理：由證型形的判準出發，一步步推導治則、治法、方藥，並以交集判準 ∩(T) 檢核每一環的吻合程度。歸納提供「古人怎麼說」的廣度，演繹保證「本案為什麼這樣治」的深度，兩者缺一不可。

◆ 服務對象與使用邊界

使用對象	核心用途	系統角色	使用邊界
執業中醫師	臨床輔助：四診結構化、辨證推演、方藥檢核、療效追蹤	輔助決策與檢核工具	處方須醫師審核簽署，系統不出具最終處方
中醫學員	學習訓練：辨證思路演練、經典對照、錯因分析	陪練式教學教官	學習輸出不可直接用於真實診療
中醫研究者	醫案結構化、文獻檢索、規律萃取	研究助理與資料工程	規律萃取僅供假設生成，須另行驗證
智慧養生使用者	體質辨識、治未病指引、食療建議	養生顧問	嚴禁診療行為；疑似疾病一律轉介醫師

> **系統紅線**
>
> AI 中醫大腦是醫療輔助系統，不是醫療行為主體。任何診斷結論與治療方案，皆須經執業中醫師覆核簽署；急危重症識別後第一優先是即時轉診，不得以系統建議延誤救治。

1.2　空間本形之運用總綱

空間本形處理「萬物如何被定義、分類、容納與檢核」。中醫知識體系龐大——數千味本草、數萬首方劑、三百餘經穴、難以窮盡的證型變化——若無明確的形結構，任何智慧系統都會退化為模糊的關鍵字檢索。空間本形於中醫的運用，可歸納為下表之總綱：全書後續所有環節，皆由此展開。

空間本形要素	於 AI 中醫大腦之運用	具體示例
形（Type）：異同→分合→邊界	中醫知識第一等公民：一切知識皆以形存在，各有明確邊界	證型形 SyndromeType、本草形 HerbType、方劑形 FormulaType 等十四形（見 2.1）

空間本形要素	於 AI 中醫大腦之運用	具體示例
屬性 / 屬性值	形之內部結構：四診表現、藥性、方義皆為屬性填值	脈形之「位、數、形、勢」；本草形之「四氣、五味、歸經、毒性」
空間容器 ( )	有邊界的容納關係：處方容納藥味、經脈容納穴位	(麻黃湯) = 容納麻黃 · 桂枝 · 杏仁 · 甘草之處方容器
形集合 SOM { }	同現屬性值的集體歸納：證候集合	{ 惡寒, 發熱, 無汗, 頭痛, 脈浮緊 }→太陽傷寒證候集
抽象 [ ]	由具體上升為一般：症狀→證型→治則	[太陽傷寒證 → 辛溫解表] 之治則抽象
BOM / SOM 對應（表頭 = 形）	方劑 BOM（藥味明細）與辨證 SOM（證候集合）雙向映射	桂枝湯 BOM ↔ 太陽中風證 SOM；知識表表頭即形
框架四步驟	一切形化作業的標準流程	形定義→屬性填值→關係連邊→判準檢核（見 2.5）
交集判準 ∩(T)	證型確立之硬閘門：患者證候集與證型判準集的量化吻合	∩(T) ≥ 臨界值方可立證；灰區強制標注（見 2.7）

1.3　時間本形之運用總綱

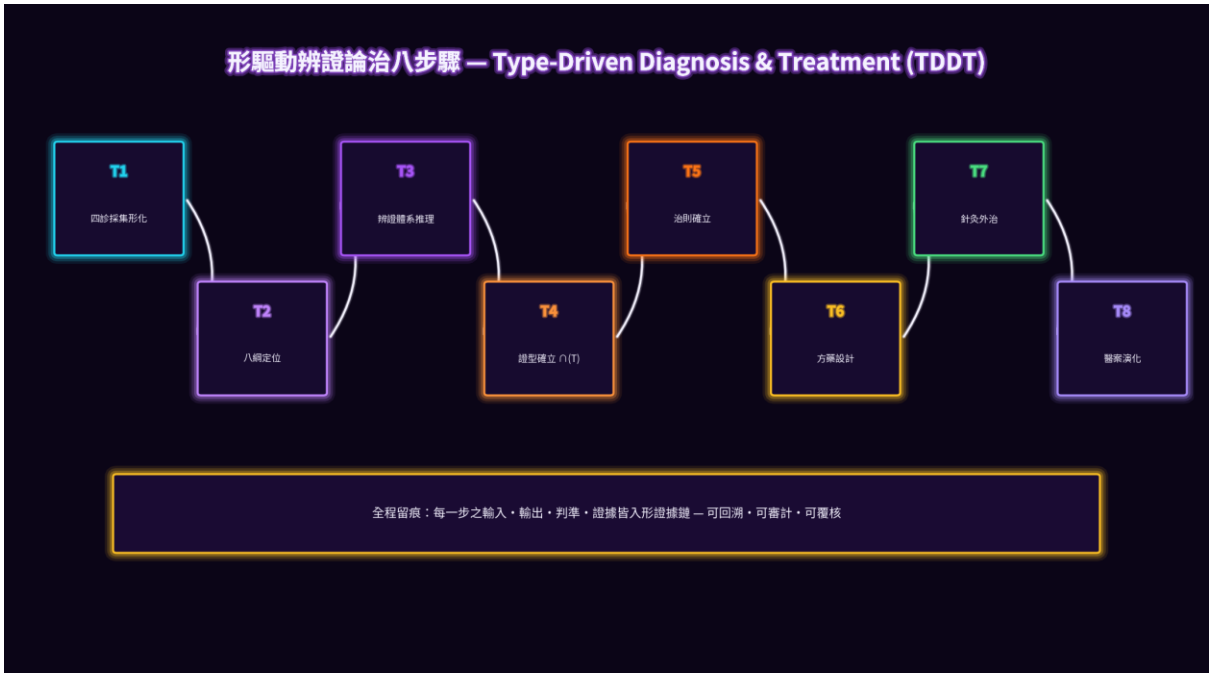
時間本形處理「狀態如何隨時間推移、推理如何在時間中展開、系統如何隨時間演化」。中醫本質上是時間性的醫學：疾病有傳變（六經傳變、衛氣營血傳變），診察有時序（初診、複診、晝夜節律），治療有時辰（服藥時間、子午流注），知識有演進（醫案沉澱、流派爭鳴）。時間本形於中醫的運用總綱如下：

時間本形要素	於 AI 中醫大腦之運用	具體示例
搜尋模式	典籍 · 醫案 · 本草的時序檢索：先查經典，再查醫案，後查近代研究	查「不寐」：內經→傷寒（少陰病但欲寐）→名醫醫案→現代研究
推理模式	辨證論治的時間推演：由現在四診推斷過去病機、預測未來傳變	由「汗出惡風脈浮緩」推斷太陽中風，預測入裡化熱之可能
設計模式	治療方案的時間設計：療程節點、服藥時辰、針灸擇時	桂枝湯「啜熱稀粥溫覆取微汗」；子午流注依時取穴

時間本形要素	於 AI 中醫大腦之運用	具體示例
自我演化	系統隨醫案累積精進：療效回饋→判準修正→知識沉澱	S7 療效評估→S8 知識沉澱→∩(T) 判準微調
病程時間軸	疾病全程的時間結構化記錄	初診（表證）→三日（表解）→七日（癒後防復）

1.4　形驅動辨證論治：TDDT 方法論

綜合雙本形，AI 中醫大腦採用「形驅動辨證論治」（Type-Driven Diagnosis & Treatment，TDDT）作為核心方法論：以形為起點，以八個步驟完成一次完整臨床推理——從四診採集的資訊形化（T1），到八綱定位（T2）、辨證體系推理（T3）、證型確立（T4），再進入治療端的治則確立（T5）、方藥設計（T6）、針灸外治（T7），最後以醫案與療效演化收束（T8）。每一步皆有明確的輸入、輸出與 ∩(T) 判準，全程留痕形成形證據鏈。



【圖】形驅動辨證論治八步驟 TDDT：每步皆有輸入・輸出・判準・全程形證據鏈留痕

TDDT 與傳統「理法方藥」完全同構，只是把心法顯性化：T1–T2 對應「四診合參」，T3–T4 對應「辨證」，T5 對應「立法」，T6–T7 對應「處方遣藥・針灸取穴」，T8 對應「醫案書寫與總結」。

差別在於：每一步的中間產物都是結構化的形實例，下一步的輸入有明確規格，任何一步出錯都可以被定位、被回放、被修正。

◆ 治法八法與 TDDT 之對應

八法	適應證型	代表方	TDDT 落點
汗法	表證：邪在皮毛	麻黃湯、桂枝湯、銀翹散	T5 立法＋T6 選方（瘡家衄家汗家禁）
吐法	痰涎宿食壅塞上脘	瓜蒂散（現少用）	T5 立法（虛人孕婦忌）
下法	裡實證：燥屎、瘀血、水飲	大承氣湯、桃核承氣湯	T5＋T6（中病即止，護胃氣）
和法	少陽不和、肝脾不和、寒熱錯雜	小柴胡湯、逍遙散、半夏瀉心湯	T3 鑑別半表半裡＋T5 立法
溫法	裡寒證：陽虛寒盛	理中丸、四逆湯、當歸四逆湯	T5 立法（陰虛者忌）
清法	裡熱證：氣營血分熱	白虎湯、清營湯、犀角地黃湯	T3 衛氣營血定位＋T5 立法
消法	氣血痰濕食積痞塊	保和丸、越鞠丸、枳實消痞丸	T5＋T6（消不傷正）
補法	虛證：氣血陰陽不足	四君子湯、四物湯、六味地黃丸	T5 立法（虛不受補先調脾）

1.5 四層準確性保證

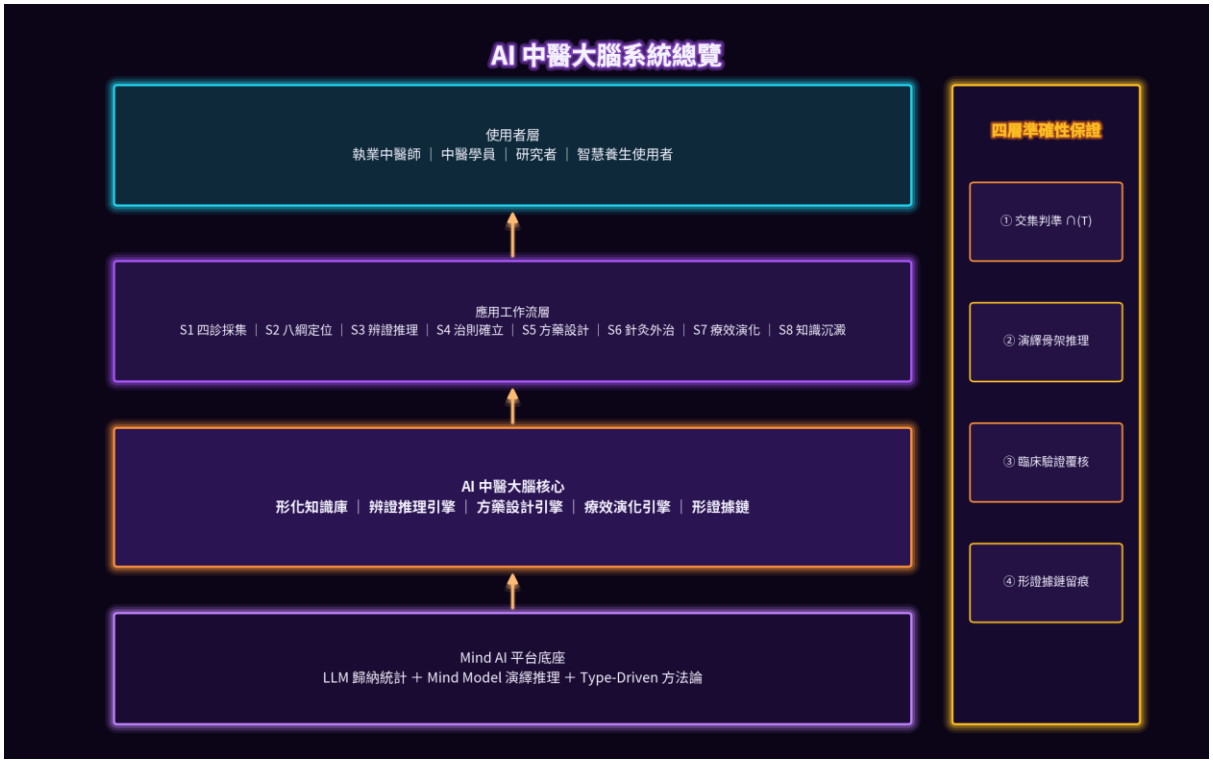
醫療輔助系統的生命線是準確性。AI 中醫大腦以四層準確性保證貫穿 TDDT 全流程：第一層「交集判準 ∩(T)」在證型確立處設硬閘門；第二層「演繹骨架推理」保證證→法→方→藥每一環可驗；第三層「臨床驗證覆核」引入執業中醫師、經典原文與文獻比對；第四層「形證據鏈留痕」使全程可回溯、可審計。任一層未通過，系統即停止出方、顯式標注不確定性並升級人工審核。



【圖】四層準確性保證：由硬閘門到留痕，逐層收斂不確定性

1.6 系統總覽架構

系統分為五層：使用者層定義四類使用者與其邊界；應用工作流層即 S1–S8 八個準確使用方法工作流（詳第 6 章）；AI 中醫大腦核心承載形化知識庫、辨證推理引擎、方藥設計引擎、療效演化引擎與形證據鏈；Mind AI 平台底座提供 LLM 歸納統計與 Mind Model 演繹推理；四層準確性保證則縱貫所有層級。



【圖】AI 中醫大腦系統總覽：五層架構 × 四層準確性護欄

1.7 文件導讀

讀者	建議路徑	重點章節
臨床醫師	第 1 章 → 第 5 章 → 第 6 章（S1–S8 手冊）→ 第 7 章	第 6 章提示詞手冊、第 7 章安全護欄
中醫學員	第 2 章 → 第 4 章（知識映射）→ 第 5 章 → 第 6 章演練	第 4 章知識全貌、第 6.9 節綜合演練
研究者	第 2 章 → 第 3 章 → 第 4.9 節 → 第 8 章附錄	形化工程方法、典籍知識源流
養生使用者	第 1.1 節（邊界）→ 第 4.7 節（體質養生）	治未病與體質辨識，其餘章節作背景閱讀

◆ 本書的使用方式

- 當作「方法書」通讀：依章序理解形化工程如何支撐辨證論治——適合首次接觸本系統者；

- 當作「手冊」查用：臨床時直接翻第 6 章取提示詞模板、翻第 8 章取速查表——適合已受訓使用者；
- 當作「教材」授課：第 4 章知識映射配合第 6.9 節演練，可作中醫辨證思維訓練的結構化教案；
- 當作「規範」引用：第 7 章安全護欄與第 2.8 節檢核清單，可直接納入機構的 AI 輔助使用規範。

版本與演化

本書所述判準與提示詞皆帶版本號。系統自我演化後，配套提示詞手冊同步出新版——使用者應以「判準版本一致」為前提跨版本比較結果，避免新舊判準混用造成不可比。

第 2 章　中醫知識形化工程 — 空間本形全面應用

本章把空間本形的全部要素——形、屬性、容器、集合、抽象、BOM/SOM、框架四步驟、交集判準——逐一落實到中醫知識的建模作業中，構成 AI 中醫大腦的「知識形化工程」規範。此後所有臨床推理的準確度，根本上取決於形化工程的品質。

2.1　中醫形分類體系：十四形總表

中醫知識的第一等公民是形。全系統定義十四個基本形，分屬診斷、藏象、治療、知識四個形群。每個形都有明確的邊界：判斷一個知識單元「是不是」某形，不靠語感，靠邊界條件——這正是「異同→分合→邊界」的操作化。



【圖】中醫形分類全景：四大形群 × 十四基本形

形	英文	定義	關鍵屬性	代表知識
症狀形	SymptomType	患者可察覺或可觀察之異常表現	部位、性質、程度、時間規律、加劇緩解因素	惡寒、發熱、頭痛、咳嗽、心悸
舌形	TongueType	舌象之結構化描述	舌色、舌形、舌態、苔色、苔質、舌下絡脈	淡紅舌薄白苔、紅舌黃膩苔
脈形	PulseType	脈象之結構化描述	位、數、形、勢、節律（寸關尺分候）	浮脈、沉脈、弦脈、滑脈、細脈
證型形	SyndromeType	疾病某階段病位病性病因之綜合判斷	病位、病性、病因、病勢、判準集合	太陽中風證、肝鬱脾虛證、心脾兩虛證
病因形	EtiologyType	致病因素之分類模型	六淫、七情、痰飲瘀血、飲食勞逸外傷	風寒束表、肝氣鬱結、瘀血阻絡
臟腑形	ZangFuType	藏象系統之功能模型	生理功能、病理特點、體竅華液、絡屬關係	心主血脈藏神、肝主疏洩藏血
經絡形	MeridianType	經脈絡屬與氣血流注模型	經脈路線、流注時辰、是動所生病	十二正經、奇經八脈、十五絡脈
氣血津液形	QiType	氣血津液之生成輸布與病變模型	生成、功能、病變類型	氣虛、血瘀、津虧、痰飲
體質形	ConstitutionType	個體相對穩定的體質特徵	九種體質分型、易感傾向、調理原則	平和質、陽虛質、痰濕質、氣鬱質
治則形	PrincipleType	治療之總體策略	標本緩急、扶正祛邪、三因制宜	治病求本、標本兼治、先表後裡
治法形	MethodType	治則之下之具體治法	八法、十劑、具體運用條件	辛溫解表、疏肝健脾、滋陰降火
方劑形	FormulaType	有機組合之處方模型	組成（君臣佐使）、功效、主治、煎服法、加減、禁忌	桂枝湯、逍遙散、六味地黃丸

形	英文	定義	關鍵屬性	代表知識
本草形	HerbType	單味藥之性用模型	四氣、五味、升降浮沉、歸經、毒性、劑量	麻黃辛溫入肺膀胱經、附子大熱有毒
穴位形	AcupointType	腧穴之定位與主治模型	定位、歸經、特定穴類別、主治、刺灸法	足三里、合谷、太沖、三陰交

此外尚有三個支撐形：病案形（CaseType，一次完整診療的時間膠囊）、典籍形（ClassicType，文獻知識的出處錨點）、養生形（RegimenType，治未病方案）。支撐形不直接參與辨證推理，卻是形證據鏈與自我演化不可或缺的載體。

2.2 屬性・屬性值設計準則

屬性是形的內部結構。屬性設計須同時滿足五項準則：其一「完備」——足以支撐該形的全部判定；其二「可判」——兩位合格醫師依屬性描述應得出一致結論；其三「可枚舉或可量化」——屬性值有閉合清單或量表；其四「可回溯」——每一個屬性值都能指回四診證據；其五「可演化」——允許隨判準精進增補新屬性值。



【圖】屬性・屬性值設計：以本草形與方劑形為例

形	屬性綱目	屬性值示例（節錄）
症狀形	部位｜性質｜程度｜時間規律｜加劇緩解因素｜伴隨症狀	頭（部位）｜脹痛（性質）｜中度（程度）｜晨起加重（時律）｜遇風加重（誘因）
舌形	舌色｜舌形｜舌態｜苔色｜苔質｜舌下絡脈	淡紅｜胖大｜歪顫｜白｜膩｜絡脈青紫迂曲
脈形	位｜數｜形｜勢｜節律｜分候	浮（位）｜遲（數）｜細（形）｜無力（勢）｜代（節律）｜左寸弱
證型形	病位｜病性｜病因｜病勢｜判準集合｜兼證夾雜	心脾（病位）｜兩虛（病性）｜思慮過度（病因）｜慢性（病勢）
本草形	四氣｜五味｜升降浮沉｜歸經｜毒性｜常用量｜特殊煎法	溫｜辛苦｜升｜肺膀胱｜小毒（麻黃）｜2–10g｜先煎去沫
方劑形	組成｜君臣佐使｜功效｜主治證型｜煎服法｜加減｜禁忌	桂枝湯｜桂枝君芍藥臣｜解肌發表調和營衛｜太陽中風證

形化設計的實務提醒

屬性值寧可先粗後精：先用「輕 / 中 / 重」三級起步，再依醫案累積細化；切忌一開始就追求無窮細分——完備而不封閉的屬性空間，會讓 ∩(T) 判準失去可操作性。

◆ 屬性值標準化：程度分級與術語詞表

屬性	標準化詞表（節錄）	分級 / 枚舉規範
程度	輕・中・重・極重	輕：可忽略不影響生活；中：明顯不適；重：影響生活起居；極重：臥床或危候
病程	急性（＜2 週）・亞急性（2–4 週）・慢性（＞4 週）	以起病至就診之時間計；反覆發作者標注發作頻度
時間規律	持續・間歇・晝重夜輕・日晡・五更・子午	按十二時辰與晝夜節律標準枚舉
加劇緩解	得溫則減・得按則減・遇怒加重・勞後加重・食後加重	與寒熱虛實鑑別直接掛鉤，須強制填寫
舌色	淡白・淡紅・紅・絳・紫・青	六值閉合清單，禁止「偏紅」等模糊語
脈象	二十八脈標準名＋位數形勢四軸	術語依《脈經》詞表；四軸分列，禁止合併描述

2.3　空間容器與形集合三括號之運用

形集合三括號是空間本形的語法：圓括號 ( ) 表容器——有邊界的容納；花括號 { } 表 SOM——同現屬性值的集合歸納；方括號 [ ] 表抽象——由具體上升為一般。三者在中醫知識中各有明確職責：



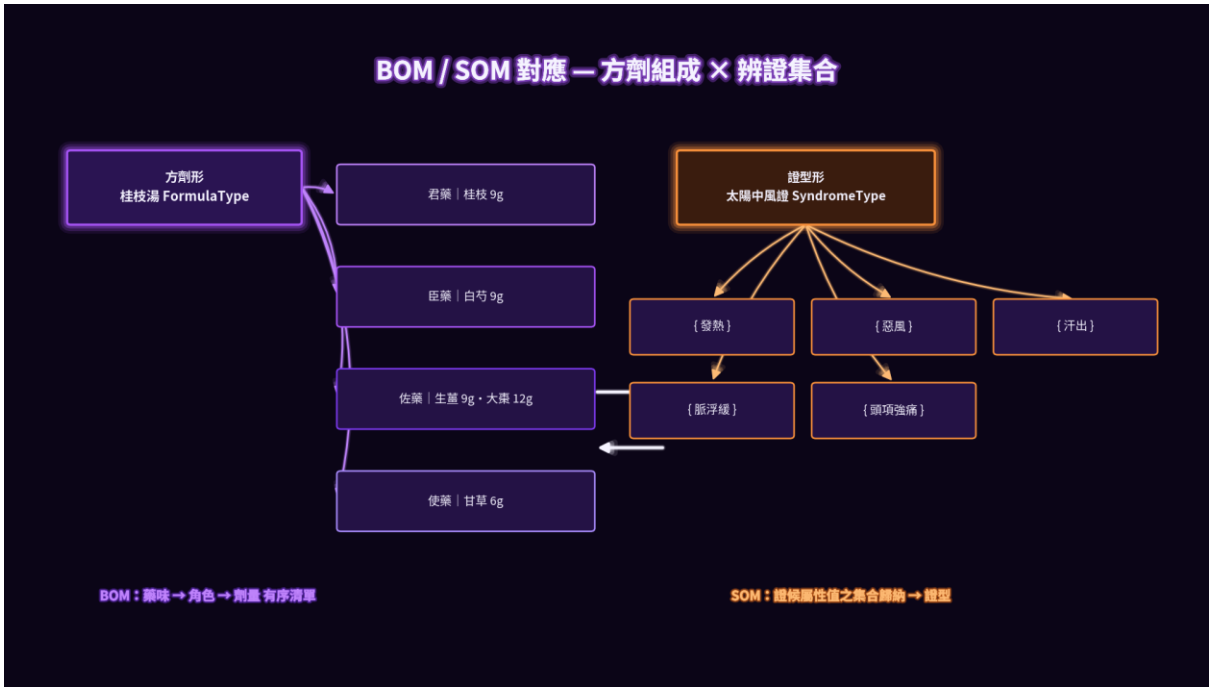
【圖】形集合三括號於中醫：處方容器・證候集合・治則抽象

括號	語法	中醫運用	操作規範
( ) 容器	有邊界的容納	處方 = 藥味容器；經脈 = 穴位容器；醫案 = 診療事件容器	容器有邊界：藥味出容器即為加減新方，須重新檢核
{ } SOM	同現屬性值集合	證候集合 = 同現症狀脈舌之歸納；藥對、藥組	SOM 成員須同現於同一患證，並標注出現頻度
[ ] 抽象	由具體到一般	症狀群→證型；證型→治則；醫案→規律	抽象須可回指：任一抽象層皆能還原為下層證據

以一則虛證醫案為例：{ 失眠多夢, 心悸健忘, 食少納呆, 面色萎黃, 脈細弱 } 依 SOM 歸納為「心脾兩虛」證候集；處方 (歸脾湯：人參、黃芪、白朮、當歸…) 以容器容納藥味；再抽象 [心脾兩虛 → 補益心脾] 成為治則。三括號一體運用，構成由症狀到處方的完整語法。

2.4 BOM / SOM 雙向對應

BOM (物料清單) 原指產品的組成明細，在中醫映射為「方劑的藥味清單」：方劑形之下，每一味藥都是帶角色 (君臣佐使) 、劑量、用法的明細項。SOM (同現集合) 映射為「證候的同現集合」：證型形之下，每一個症狀脈舌都是帶權重的同現項。二者的雙向對應，是「方證對應」這一中醫核心命題的形化表達：

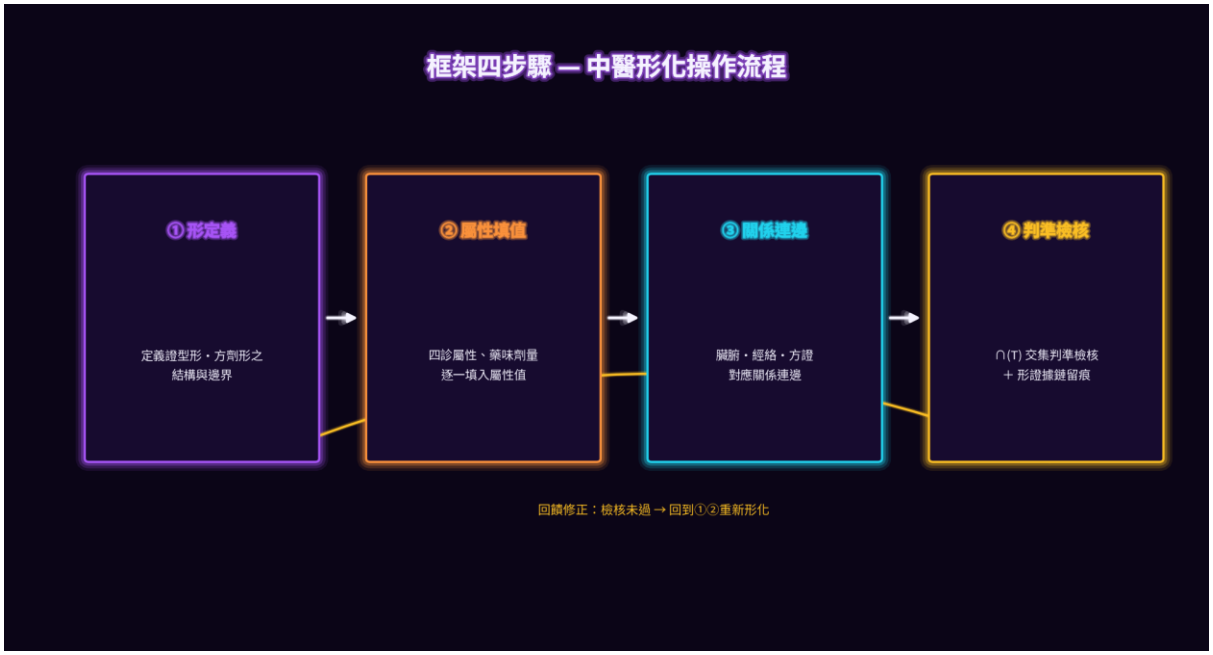


【圖】BOM / SOM 對應：方劑藥味清單 × 證候同現集合

對應方向	操作	示例（桂枝湯 ↔ 太陽中風證）	檢核要點
SOM → BOM（由證出方）	證候集合匹配方劑形主治，組成藥味 BOM	{發熱,惡風,汗出,脈浮緩}→桂枝湯	君藥須直指主證；全方功效覆蓋證候全集
BOM → SOM（由方測證）	由藥味性味歸經反推可治證候集合	桂枝湯 BOM→解肌發表，調和營衛→太陽中風	反推 SOM 不得超出原方主治邊界
加減對應	兼證 SOM 增項→BOM 對應增減藥味	兼項{項背強几几}→加葛根	加減後須整方重新 ∩(T) 檢核

2.5 框架四步驟之操作規範

一切形化作業——無論定義一個新證型、建一味本草，還是錄一則醫案——都遵循框架四步驟：



【圖】框架四步驟：形定義→屬性填值→關係連邊→判準檢核

步驟	輸入	操作	輸出與檢核
① 形定義	知識單元類型與文獻依據	確定形之邊界：哪些屬性必備、哪些特徵排除	形規格書；邊界條件可判定性檢核
② 屬性填值	四診證據・文獻原文	逐屬性填入屬性值，標注證據來源	屬性實例；空缺值顯式標注「未採集」
③ 關係連邊	形實例之間的關聯	連接方證、藥證、穴證、臟腑絡屬等邊	知識圖邊集；邊皆有方向與語義
④ 判準檢核	∩(T) 判準	吻合度計算、灰區判定、醫師覆核	檢核報告；未過者回①②修正

四步驟的價值在於強制性：任何跳過「判準檢核」直接入庫的知識，都會在日後的推理中以幻覺的形式付出代價。檢核未過的項目回到起點重新形化，形成封閉的品質迴圈。

2.6 RDB 對應原則：表頭即形

空間本形與關聯式資料庫（RDB）有天然對應：形即表頭（Schema），形的實例即資料列，形的關係即外鍵。這一對應使形化知識庫可以無縫落地為資料表，也使「表設計」與「形設計」成為同一份工作的兩個視角。下表為核心知識表的概念設計：

知識表	表頭（＝形）	關鍵欄位（節錄）
證型表	證型形 SyndromeType	證型編碼｜病位｜病性｜病因｜判準集合 SOM｜治則｜來源典籍
本草表	本草形 HerbType	藥名｜四氣｜五味｜歸經｜毒性｜常用量｜配伍禁忌｜炮製
方劑表	方劑形 FormulaType	方名｜組成 BOM｜君臣佐使｜功效｜主治｜煎服法｜加減｜禁忌
穴位表	穴位形 AcupointType	穴名｜歸經｜定位｜特定穴類別｜主治｜刺法｜灸量
醫案表	病案形 CaseType	案號｜四診記錄｜證型推演鏈｜處方｜療效｜時間軸節點｜審核醫師

設計時須把握三點：第一，表頭欄位的取捨以形規格書為準，不因臨時需求增刪；第二，判準集合 SOM 與組成 BOM 這類集合型屬性，以子表實現（證候表、藥味表），維持第一正規化；第三，每張知識表都保留「來源典籍」與「版本」欄位——典籍形的出處錨點，是形證據鏈的文獻端點。

2.7　交集判準 ∩(T) 之形式化

交集判準 ∩(T) 是證型確立的硬閘門。設患者證候集 P（由 S1–S2 形化而來）與證型判準集 T（證型形的核心屬性集合），則 ∩(T) 吻合度定義為二者的加權重合程度：權重依證候對該證型的鑑別力分配（主證權重高、次證權重低、舌脈常為關鍵權重）。



【圖】交集判準 ∩(T)：患者證候集與證型判準集的量化吻合

吻合度區間	判定	系統行為
∩(T) ≥ 0.85	證型確立	進入 T5 治則推導；標注支持證據與殘餘疑點
0.70 ≤ ∩(T) < 0.85	證型傾向（灰區）	並列次選證型；標注鑑別要點；建議補充四診資訊
∩(T) < 0.70	證型不成立	退回 S3 重新辨證；禁止以弱吻合強行出方

計算要素	說明	示例（太陽傷寒證 T）
主證（權重 3）	該證型的必要或高度特異證候	惡寒、無汗、脈浮緊
次證（權重 2）	常見支持證候	頭項強痛、身疼痛、發熱
舌脈佐證（權重 2）	關鍵鑑別證據	苔薄白、脈浮緊有力
反證（扣分）	與判準衝突者	汗出（反對無汗）→ 扣分並提示桂枝湯證鑑別

灰區是特性不是缺陷

中醫辨證本有「疑似之間」的傳統——《傷寒論》中大量條文正是鑑別診斷。系統在灰區強制並列證型與鑑別要點，正是還原中醫思維的本來面目；最危險的不是灰區，而是把灰區強行判成確證。

2.8　形化品質檢核清單

每完成一批知識形化，依下表逐項檢核。全數通過方可入庫；任一項未過，退回對應步驟修正。

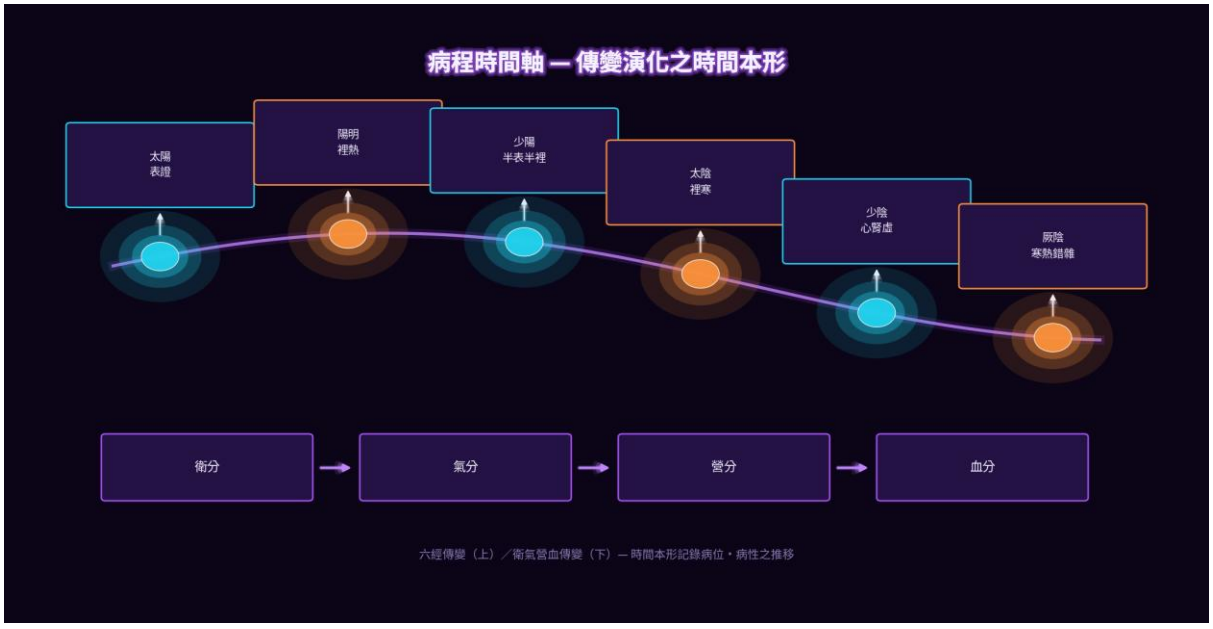
檢核項	判定標準	未過處理
邊界可判性	兩位醫師依形規格獨立判定結論一致	回①重定義邊界
屬性完備度	必備屬性無空缺；空缺皆顯式標注	回②補填或標注
證據可回溯	每屬性值可指回四診記錄或典籍原文	回②補證據來源
關係有語義	每條邊有方向與關係類型	回③重連邊
∩(T) 可計算	判準集合與權重完整，可重算吻合度	回④補判準
版本可追溯	來源典籍、修改記錄、審核人齊備	補版本資訊

第 3 章　時間本形於中醫動態推理

中醫是時間性的醫學。疾病在時間中傳變，診察在時間中展開，治療在時間中生效，知識在時間中演進。時間本形的五大要素——病程時間軸、搜尋、推理、設計、自我演化模式——在 AI 中醫大腦中各有明確落點，使系統不僅能回答「這是什麼證」，更能回答「這個證從哪裡來、往哪裡去、何時介入、如何演化」。

3.1　病程時間軸與傳變形

病程時間軸把一次疾病歷程結構化為節點序列：起病節點（病因介入與初現症狀）、演變節點（證型轉折）、介入節點（治療開始與方案調整）、結局節點（痊癒、好轉、傳變、惡化）。每個節點都是一組時間戳記的四診屬性快照，節點之間的變化方向即是「傳變」。



【圖】病程時間軸：六經傳變與衛氣營血傳變的時間結構

傳變不是隨機的——中醫經典為傳變提供了三套成熟的方向圖：六經傳變描述傷寒由表入裡的層級推移，衛氣營血傳變描述溫病由淺入深的四個階段，三焦傳變描述溫邪由上焦向中下焦的縱向發展。系統以「傳變形」記錄每一次移動的起訖、條件與證據，使病勢判斷（《傷寒論》所謂「觀其脈證，知犯何逆，隨證治之」）成為可計算的推理。

3.2 三大傳變體系的時間結構

傳變體系	階段序列	轉折指徵	臨床意義
六經傳變	太陽→陽明→少陽→太陰→少陰→厥陰	由表入裡、由寒轉熱或由熱轉寒；直中、兩感、合病併病為變局	傷寒外感病的定位與預後判斷
衛氣營血	衛分→氣分→營分→血分	發熱特徵、神志變化、斑疹出血、舌象推移	溫病熱性病的深淺與險候識別
三焦傳變	上焦（肺衛心包）→中焦（脾胃）→下焦（肝腎）	病位縱向推移；濕溫多沿三焦漫延	濕溫與溫病的病位判斷
臟腑傳變	母病及子、子盜母氣、乘侮傳變	五臟生剋關係決定的擴散路徑	內傷雜病的病勢推演

傳變判斷的時間紀律

傳變判斷必須給出「時間證據」：何時出現新症狀、何時舌脈改變、何時加重緩解。沒有時間戳記的「傳變」只是猜測——系統要求每一個傳變結論都附上節點對照，正是把《溫病條辨》「入營猶可透熱轉氣」的時機醫學落到實處。

3.3 四診動態採集與時間序列

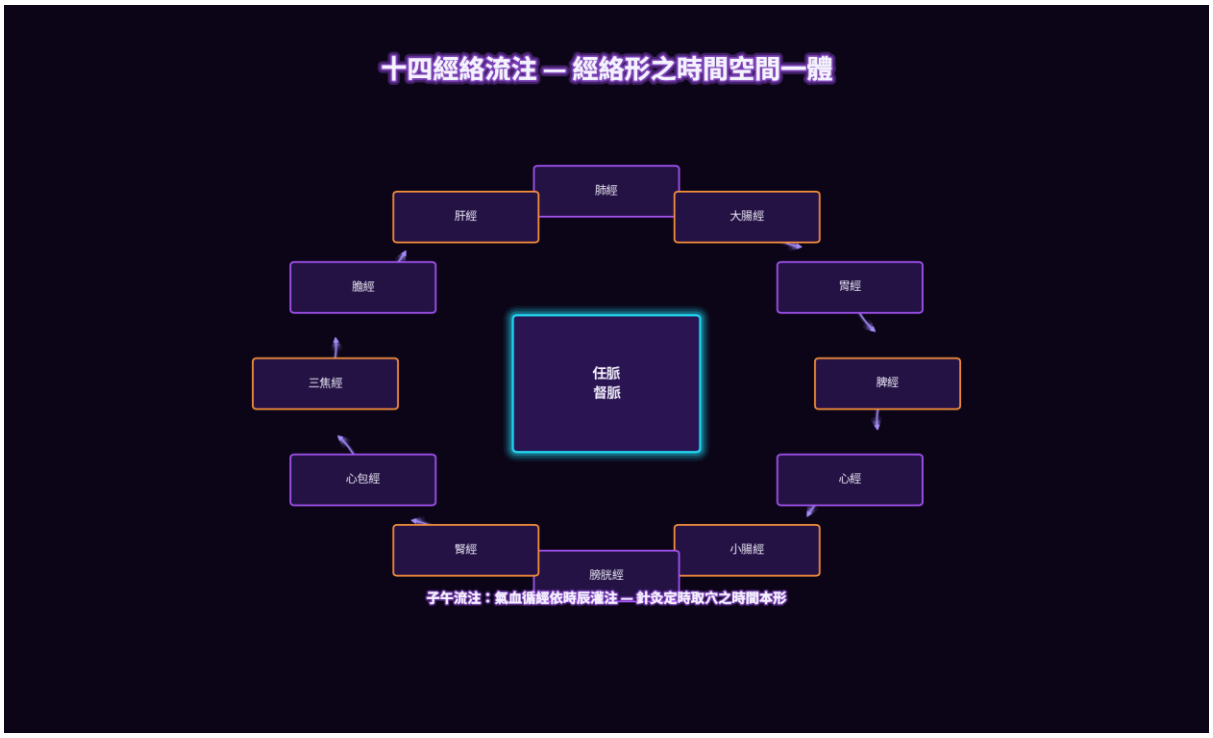
四診不是一次性的快照，而是時間序列。系統在四診屬性中內建時間欄位：症狀形的起病時間、持續時間、晝夜規律（如陽虛之晨瀉、陰虛之盜汗）、加重緩解因素；脈形的至數與節律本身就是時間屬性（遲、數、促、結、代）；舌形的動態推移（苔由白轉黃、由薄轉膩）是病機熱化、濕化的直接證據。

時間屬性	所屬形	示例	臨床價值
起病與病程	症狀形	惡寒三日、發熱兩日	判斷病程階段與傳變速度
晝夜節律	症狀形	日晡潮熱、五更洩瀉、盜汗	病位病性鑑別（陽明潮熱 vs 陰虛潮熱）

時間屬性	所屬形	示例	臨床價值
加劇緩解規律	症狀形	得溫則減（虛寒）、遇怒加重（肝鬱）	寒熱虛實鑑別的重要砝碼
脈之至數節律	脈形	一息四至為常、代脈動而中止	心氣盛衰與預後判斷
舌象推移	舌形	薄白苔→黃膩苔（三日）	病機熱化濕化的客觀化指標

3.4 治療時間軸：服藥時辰・子午流注・療程節點

治療同樣在時間中展開。中醫對給藥時辰有精細講究：補益藥宜飯前、消導藥宜飯後、安神藥宜睡前、截瘧藥宜發前；針灸則有子午流注——氣血循經依時辰灌注，某經當令之時取其穴效果最著。系統以「治療時間軸」管理療程：每個療程節點安排複診四診、療效評估與方案調整。



【圖】十四經絡流注：子午流注的時間空間一體結構

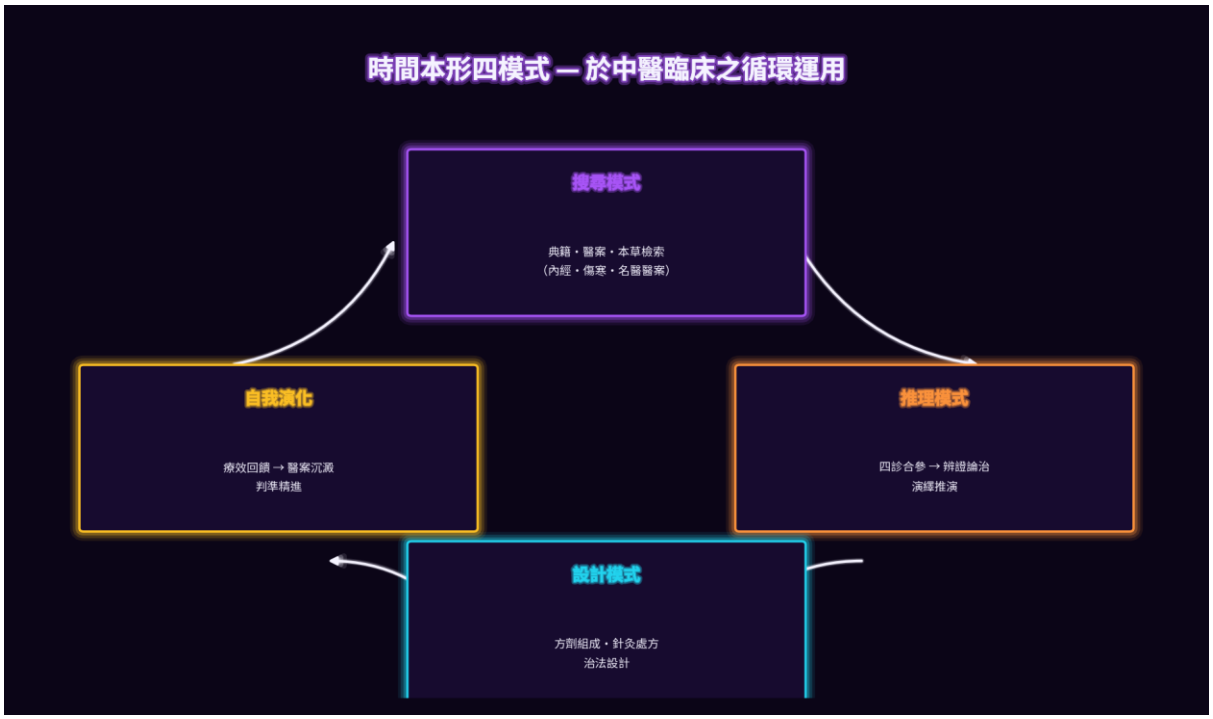
時辰	當令經脈	針灸運用	服藥參考
寅時 03–05	肺經	咳喘哮證取肺經穴	補肺藥黎明前服
辰時 07–09	胃經	胃脘痛取足三里	健胃藥早飯前後
午時 11–13	心經	心悸不寐取神門	養心藥午後服

時辰	當令經脈	針灸運用	服藥參考
酉時 17–19	腎經	腎虛腰痛取太溪	補腎藥晚飯前
亥時 21–23	三焦經	水腫調三焦	利水藥傍晚服
子時 23–01	膽經	口苦脅痛取陽陵泉	和解劑睡前一服

療程節點的標準節奏為「首診立方案、三日看轉歸、七日評療效、十四日定進退」——急性病節奏加密，慢性病放寬。每個節點執行 S7 療效演化工作流，節點間隔本身也是病勢信息：如期轉歸為順，逾期不變為滯，反而加重為逆。

3.5　時間本形四模式之臨床循環

時間本形的四模式在臨床上首尾相接、循環運轉：搜尋模式為辨證提供文獻與醫案證據，推理模式完成辨證論治推演，設計模式產出處方與針灸方案，自我演化模式以療效回饋收束——一次診療的終點，正是系統與醫師共同成長的起點。



【圖】時間本形四模式：搜尋→推理→設計→自我演化之臨床循環

模式	臨床動作	系統支援	產出
搜尋模式	「此證古人如何論治？」	典籍檢索：內經傷寒條文、名醫醫案、近代研究	證據清單（附出處篇章）
推理模式	「本案病機為何？」	四診合參→八綱→辨證體系→∩(T) 檢核	證型結論＋鑑別診斷
設計模式	「如何立法處方？」	治則推導→君臣佐使組方→禁忌檢核	處方＋針灸方案＋療程
自我演化	「療效如何？學到什麼？」	前後對照→規律萃取→判準精進提案	療效報告＋醫案入庫＋判準提案

3.6　自我演化：療效回饋與判準精進

自我演化是時間本形的最高形態，也是 Mind AI 區別於靜態知識庫的關鍵。其閉環為：醫案完整入庫（S8）→ 療效結局與辨證鏈比對 → 提取「預測—結果」偏差 → 若偏差可歸因於判準（如某證候權重過低），則生成 ∩(T) 判準修正提案；若歸因於辨證疏漏，則生成鑑別要點補充提案。所有提案經醫師審核會議通過後才進入判準版本——演化永遠在人工閘門之後。

演化類型	觸發條件	提案內容	審核要求
判準權重精進	同類醫案反覆出現系統性偏差	∩(T) 權重調整提案	醫師組審核＋樣本量門檻
鑑別要點補充	灰區誤判率偏高	證型鑑別對照表增補	須附誤判醫案證據
方藥加減沉澱	名醫醫案高頻加減反覆出現	加減規則入庫提案	須標注流派與適用邊界
新證型候選	大量醫案聚集於現有證型之外	新證型形候選規格書	須文獻依據＋多醫師共識

演化的保守原則

寧可漏演化，不可誤演化。所有演化提案默認「不生效」，通過審核閘門前，臨床推理一律使用現行判準版本——保證同一醫案在任何時刻重放，結果可複現。

第 4 章　中醫全科知識映射 — 九大知識域

本章是全書的知識底座：把中醫全科知識——基礎理論、診斷、辨證體系、中藥、方劑、針灸、養生、專科、典籍——逐一映射為形結構。內容力求全備，作為形化知識庫的藍本與 S1–S8 工作流的知識後盾。

4.1　中醫基礎理論形化

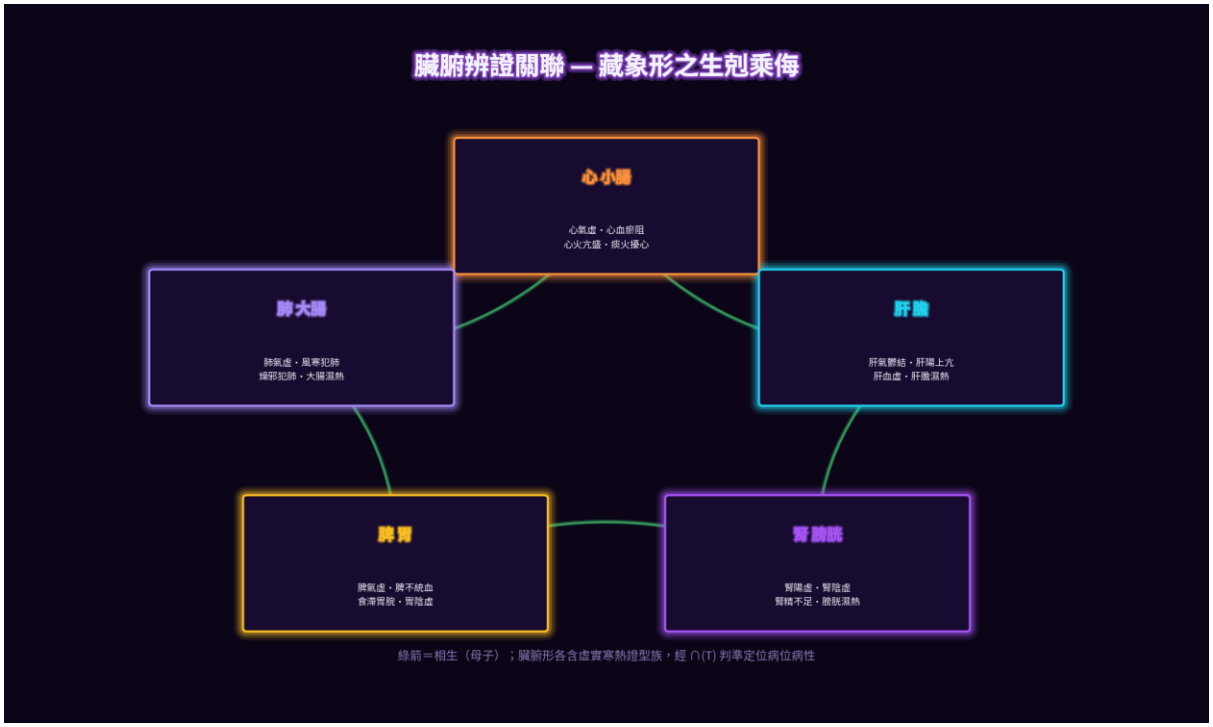
◆ 陰陽五行：總綱與關係模型

陰陽是中醫的總綱辨證（八綱之綱），五行是藏象之間的關係模型。形化要點：陰陽作為「二值判斷軸」貫穿所有證型形的病性屬性；五行生剋乘侮作為臟腑形之間的「關係邊類型」——生（母子相生）、克（制約平衡）、乘（克制太過）、侮（反向欺凌）。

五行	臟	腑	五官	五志	五味	病變特徵
木	肝	膽	目	怒	酸	疏洩失常：鬱結、上亢、動風
火	心	小腸	舌	喜	苦	血脈神志失常：悸、煩、不寐
土	脾	胃	口	思	甘	運化失常：虛、瀉、腫、不統血
金	肺	大腸	鼻	悲	辛	宣降失常：咳、喘、痰、便秘
水	腎	膀胱	耳	恐	鹹	藏精失常：虛、洩、水腫、骨弱

◆ 藏象：臟腑形的功能模型

藏象學說是中醫的「人體功能學」。形化要點：每個臟腑形定義生理功能、病理特點、體竅華液、絡屬關係四組屬性，並以關係邊連接相表裡的臟腑（心—小腸、肺—大腸、脾—胃、肝—膽、腎—膀胱）。



【圖】臟腑辨證關聯：藏象形之生剋乘侮與證型族

臟腑	核心功能	病理特點	常見證型族
心・小腸	主血脈、藏神明；小腸主泌別清濁	血脈與神志失常	心氣虛、心陽虛、心血虛、心陰虛、心火亢盛、心血瘀阻、痰迷心竅、痰火擾心
肺・大腸	主氣司呼吸、通調水道、朝百脈；大腸主傳導	宣降失常、衛表不固	肺氣虛、肺陰虛、風寒犯肺、風熱犯肺、燥邪犯肺、痰濕阻肺、大腸濕熱、大腸津虧
脾・胃	主運化統血、升清；胃主受納腐熟、降濁	運化升降失常	脾氣虛、脾陽虛、脾不統血、脾虛下陷、寒濕困脾、濕熱蘊脾、胃陰虛、食滯胃脘、胃寒、胃熱
肝・膽	主疏洩、藏血、主筋；膽主決斷貯精汁	疏洩失常、易鬱易亢	肝氣鬱結、肝火上炎、肝血虛、肝陰虛、肝陽上亢、肝風內動、寒滯肝脈、肝膽濕熱、膽鬱痰擾
腎・膀胱	藏精主骨生髓、主水納氣；膀胱主氣化	藏精不足、水液失調	腎陽虛、腎陰虛、腎精不足、腎氣不固、腎不納氣、膀胱濕熱

◆ 氣血津液：功能物質模型

物質	生成與功能	病變類型	代表證候
氣	元氣・宗氣・營氣・衛氣；推動溫煦防禦固攝	氣虛、氣滯、氣逆、氣陷、氣閉、氣脫	倦怠氣短（氣虛）、脹痛走竄（氣滯）、噯氣嘔逆（氣逆）
血	營氣津液化赤；濡養全身、神志活動基礎	血虛、血瘀、血熱、血寒	面色萎黃（血虛）、刺痛舌紫（血瘀）、斑疹吐衄（血熱）
津液	濡潤充養、代謝調節	津液不足、水濕停聚、痰飲	口乾便結（津虧）、水腫尿少（水停）、痰多苔膩（痰飲）

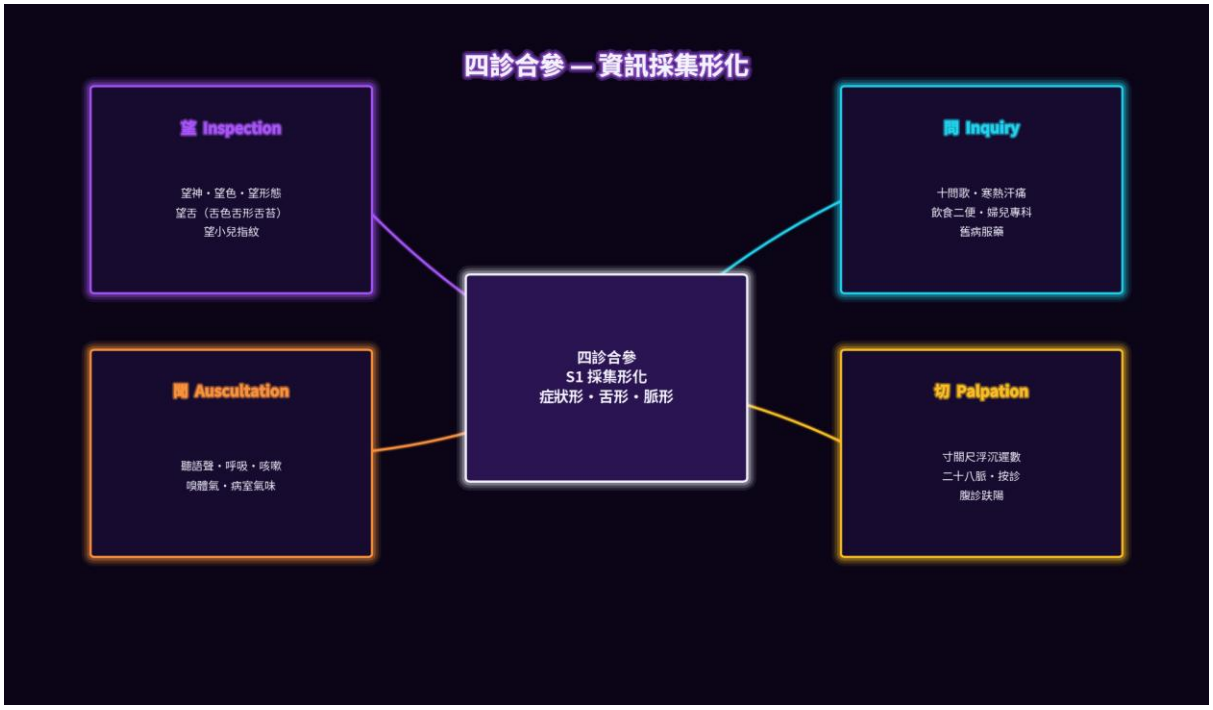
◆ 病因：病因形分類

病因形採三級分類：外感（六淫：風寒暑濕燥火・疫癘）、內傷（七情：喜怒憂思悲恐驚）、不內外因（飲食不節、勞逸失度、外傷、痰飲、瘀血、結石）。每一病因形都攜帶「致病特徵」屬性——風性善行數變、寒性凝滯收引、濕性重濁黏滯、火性炎上急迫——這正是由症狀反推病因的判準來源。

六淫	性質	症狀特徵	常見證候
風	善行數變、為百病之長	游走性、變化快、癢、抽搐	風寒束表、風熱犯肺、風邪犯絡、肝風內動
寒	凝滯收引、易傷陽氣	冷痛固定、拘急、清稀	寒邪客表、寒凝心脈、寒滯肝脈、脾胃虛寒
暑	炎熱升散、耗氣傷津、多夾濕	高熱、汗多、口渴、倦怠	中暑、暑濕感冒
濕	重濁黏滯、趨下、礙運化	身重、苔膩、病程纏綿、便溏	寒濕困脾、濕熱蘊脾、膀胱濕熱
燥	乾澀傷津、易傷肺	乾咳、口鼻乾、皮燥便結	涼燥、溫燥、肺陰虧虛
火	炎上急迫、傷津動血生風	紅腫熱痛、高熱、出血、神昏	心火亢盛、肝火上炎、胃火熾盛、熱入營血

4.2 中醫診斷學：四診全項形化

四診是資訊入口，其形化品質決定一切後續推理。以下按望聞問切給出全項綱目。



【圖】四診合參：望聞問切的資訊採集形化

◆ 望診

望診項	觀察內容	常見表現	主病意義
望神	得神・失神・假神・神亂	目光靈活、反應敏銳（得神）	得神者昌；失神者亡；假神為迴光返照
望色	青赤黃白黑五色	面色萎黃、兩顴潮紅、面色黧黑	黃主脾虛濕蘊；赤主熱；青主寒痛驚風；白主虛寒失血；黑主腎虛水飲瘀血
望形態	形體胖瘦、姿態動靜	形盛氣虛、角弓反張、瞤動瘛瘲	肥人多痰濕；瘦人多虛火；動風見抽搐震顫
望舌	舌色舌形舌態苔色苔質	淡白舌、胖大齒痕、黃膩苔	舌診為望診之核心，另立專表
望小兒指紋	風氣命三關、浮沉淡滯	指紋紫紅、透關射甲	三歲以下小兒脈診之替代：浮沉分表裡、紅紫辨寒熱

舌象要素	常見類型	主病	形化屬性值
舌色	淡白・淡紅・紅・絳・紫・青	淡白主虛寒；紅絳主熱入營血；紫青主瘀血寒凝	舌色 = 淡白 | 淡紅 | 紅 | 絳 | 紫 | 青
舌形	老嫩・胖瘦・裂紋・齒痕・芒刺	老主實；嫩主虛；胖大齒痕主脾虛濕盛；裂紋主陰津虧	舌形屬性多值可並存
舌態	痿軟・強硬・歪斜・顫動・吐弄	歪斜主中風先兆；顫動主肝風；強硬主熱入心包	舌態異常多屬重症警訊
苔質	厚薄・潤燥・腐膩・剝落・真假	膩主痰飲濕濁；腐主食積痰濁；剝落主胃氣陰兩傷	苔質是病機濕、食、傷陰的關鍵
苔色	白・黃・灰黑	白主表寒；黃主裡熱；灰黑主裡熱極或寒極	苔色推移是病機熱化的動態指標

◆ 聞診與問診

聞診含聽聲音（語聲強弱、譫語鄭聲獨語、呼吸喘哮、咳嗽嘔逆噯氣太息、呃逆）與嗅氣味（口氣、體氣、病室氣味）。問診以十問歌為綱：一問寒熱二問汗，三問頭身四問便，五問飲食六問胸，七聾八渴俱當辨，九問舊病十問因，再兼服藥參機變；婦女尤必問經期，遲速閉崩皆可見；再添片語告兒科，天花麻疹全占驗。

問診項	鑑別要點	臨床意義
寒熱	惡寒發熱並見（表證）/ 但寒不熱（裡寒）/ 但熱不寒（裡熱）/ 寒熱往來（少陽）	八綱表裡寒熱的第一入口
汗	自汗（氣虛陽虛）/ 盜汗（陰虛）/ 大汗（亡陽或裡熱）/ 無汗（表實或津虧）	汗為心之液，虛實關鍵鑑別
頭身	頭痛部位經絡歸屬、身痛重著與游走	六經頭痛有分部：太陽後項、陽明前額、少陽兩側、厥陰巔頂
二便	便秘溏結、尿清尿赤、頻急痛澀	裡熱裡寒、膀胱濕熱的直接證據
飲食口味	納呆厭食、消穀善飢、口渴喜飲冷熱	脾胃功能與寒熱真假鑑別
胸腹	脅脹、心悸、胸悶、脘痞	病位在心肝脾胃的定位依據

問診項	鑑別要點	臨床意義
耳目	耳鳴耳聾、目眩目赤	腎開竅於耳、肝開竅於目
渴不渴	不渴（寒或濕）/ 渴喜冷飲（裡熱）/ 渴不欲飲（濕或瘀）	津液存亡與病性鑑別
舊病與因	既往病史、發病誘因（情志、飲食、勞倦）	病因形判定與體質形修正

◆ 切診（脈診與按診）

脈診以寸關尺分候臟腑（左寸心、左關肝、左尺腎；右寸肺、右關脾、右尺命門），以浮沉遲數滑澀虛實為綱，二十八脈各有體象主病。按診含按肌膚、按手足、按脘腹（虛里、痞滿結聚）。

脈綱	代表脈	脈象	主病
浮脈類	浮・洪・芤・革	輕取即得、重按稍減	表證（浮）；氣分熱盛（洪）；失血傷陰（芤）
沉脈類	沉・伏・牢	輕取不應、重按始得	裡證（沉）；邪閉厥逆（伏）；陰寒內實（牢）
遲脈類	遲・緩・澀・結	一息不足四至	寒證（遲）；濕證或平人（緩）；氣滯血瘀精傷（澀）；陰盛氣結（結）
數脈類	數・疾・促・動	一息五至以上	熱證（數）；陽極陰竭（疾）；陽熱亢盛氣滯痰瘀（促）
虛脈類	虛・微・細・代	應指無力	虛證（虛）；陽氣暴脫（微）；氣血兩虛濕盛（細）；臟氣衰微（代）
實脈類	實・滑・弦・緊	應指有力	實證（實）；痰飲食滯實熱（滑）；肝膽病痛證（弦）；寒痛宿食（緊）

4.3 辨證體系大全

辨證體系是中醫的推理引擎。系統並行支持八大辨證體系，並依病種自動推薦主用體系：外感熱病首選六經或衛氣營血三焦，內傷雜病首選臟腑辨證，經絡病變首選經絡辨證，起手定位一律先過八綱。

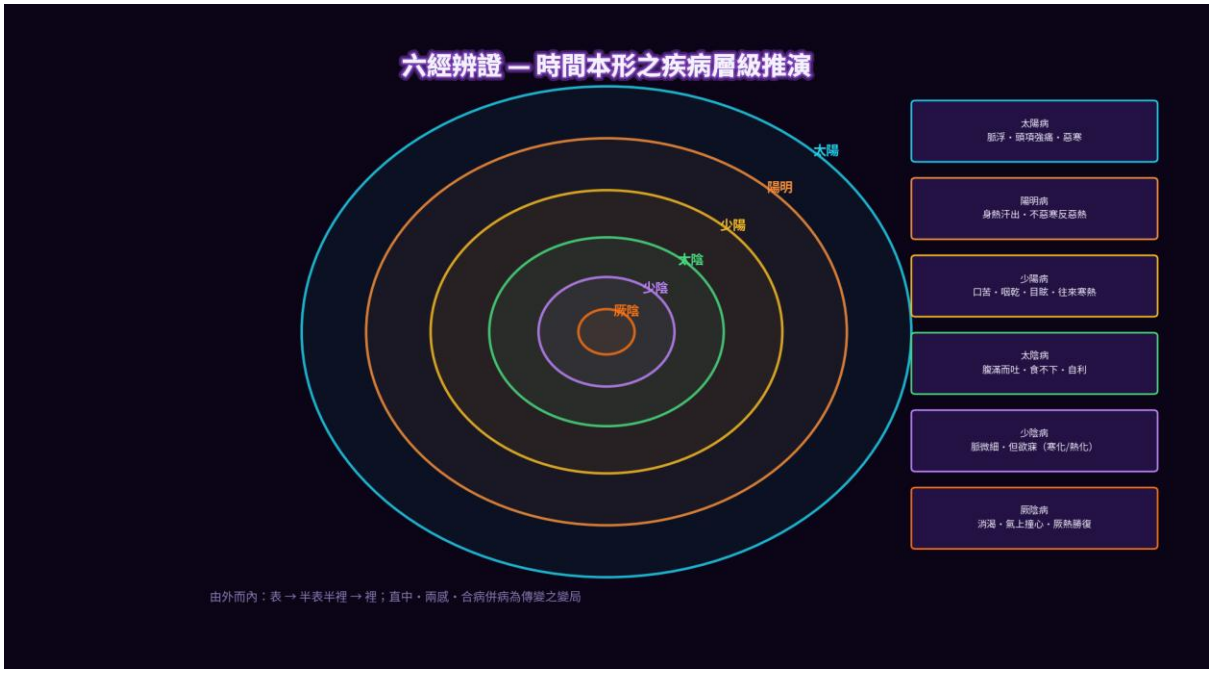
◆ 八綱辨證（總綱）



【圖】八綱辨證矩陣：陰陽總綱 × 表裡寒熱虛實

綱	證型	辨證要點	鑑別
表裡	表證 / 裡證 / 半表半裡	表：發熱惡寒並見、脈浮、病淺；裡：但寒但熱、臟腑症狀	表裡同病、表邪入裡、裡邪出表須動態判斷
寒熱	寒證 / 熱證	寒：冷白稀潤靜；熱：紅黃乾稠動	真寒假熱、真熱假寒的寒熱真假為重症關鍵
虛實	虛證 / 實證	虛：久病、聲低、痛喜按、脈無力；實：新病、聲高、痛拒按、脈有力	虛實夾雜、真實假虛、真虛假實
陰陽	陰證 / 陽證	總綱：表熱實屬陽；裡寒虛屬陰	亡陰（汗熱味鹹）與亡陽（汗冷味淡）為危候

◆ 六經辨證（傷寒體系）



【圖】六經辨證：由外而內的疾病層級推演

六經	提綱	主要證型	代表方
太陽病	脈浮、頭項強痛而惡寒	太陽中風（表虛：汗出惡風脈浮緩）；太陽傷寒（表實：無汗身痛脈浮緊）	桂枝湯；麻黃湯
陽明病	胃家實是也	陽明經證（大熱大汗大渴脈洪大）；陽明腑證（潮熱譫語腹滿便秘）	白虎湯；大承氣湯
少陽病	口苦、咽乾、目眩	少陽病：往來寒熱、胸脅苦滿、嘿嘿不欲飲食	小柴胡湯
太陰病	腹滿而吐、食不下、自利益甚	太陰虛寒：腹痛喜溫按、便溏	理中丸
少陰病	脈微細、但欲寐	少陰寒化（惡寒踡臥、下利清穀）；少陰熱化（心煩不寐、舌紅）	四逆湯；黃連阿膠湯
厥陰病	消渴、氣上撞心、心中疼熱	寒熱錯雜、厥熱勝復、蚘厥	烏梅丸

◆ 六經病鑑別與傳變要點

鑑別項	要點	臨床意義
太陽中風 vs 太陽傷寒	汗出脈浮緩（表虛）/ 無汗脈浮緊（表實）	桂枝湯與麻黃湯的分水嶺
陽明經證 vs 陽明腑證	大熱大汗大渴脈洪大 / 潮熱譫語腹滿便秘	白虎湯清氣 vs 承氣湯攻下
少陽病 vs 太陽病	寒熱往來、胸脅苦滿 vs 惡寒發熱並見	和解 vs 發汗，禁汗吐下
少陰寒化 vs 少陰熱化	惡寒踡臥下利清穀脈微 vs 心煩不寐舌紅脈細數	四逆湯回陽 vs 黃連阿膠湯育陰
厥陰蛔厥 vs 真熱假寒	吐蛔、飢不欲食、厥熱勝復	烏梅丸寒熱並用，誤判則殤
直中 vs 傳經	初起即見三陰證 vs 由太陽循經傳入	直中多因正虛寒盛，治宜急溫

◆ 衛氣營血與三焦辨證（溫病體系）

階段	辨證要點	舌象	治則與代表方
衛分證	發熱微惡風寒、頭痛口渴、脈浮數	舌邊尖紅苔薄白	辛涼解表——銀翹散、桑菊飲
氣分證	但熱不寒、汗多渴飲、苔黃脈洪數	舌紅苔黃	清氣分熱——白虎湯；熱結腸腑用承氣
營分證	身熱夜甚、心煩譫語、斑疹隱隱	舌絳無苔	清營透熱——清營湯「入營猶可透熱轉氣」
血分證	吐衄便血、斑疹透露、神昏動風	舌深絳	涼血散血——犀角地黃湯；動風用大定風珠
上焦（溫病）	邪犯肺衛或逆傳心包	薄黃或絳	辛涼清上焦；逆傳心包用安宮牛黃丸
中焦（溫病）	陽明熱盛或太陰濕熱	黃燥或黃膩	清熱攻下或化濕清熱
下焦（溫病）	肝腎陰虛、虛風內動	絳而少苔	滋陰息風——大定風珠、三甲復脈湯

◆ 臟腑辨證、氣血津液辨證、經絡辨證

臟腑辨證（見 4.1 證型族表）是內傷雜病的主力；氣血津液辨證把病性細化為氣血津液的虛滯逆陷；經絡辨證以病位循經歸屬——頭痛分六經、脅痛責肝膽、腰背痛屬膀胱經，是針灸取穴的直接依據。

4.4　中藥學：本草形的完整屬性空間

中藥學的形化圍繞本草形展開：四氣（寒熱溫涼）定病性相逆，五味（酸苦甘辛鹹淡澀）定作用趨勢（辛散酸收甘緩苦堅鹹軟），升降浮沉定作用方向，歸經定作用部位，毒性定安全邊界。配伍關係七情（單行、相須、相使、相畏、相殺、相惡、相反）與禁忌（十八反、十九畏、妊娠禁忌）是方藥設計的安全底線。



【圖】本草分類十四門：本草形之屬性空間

分類	功效	代表藥	性味	要點
解表藥	發散表邪	麻黃桂枝（辛溫）；薄荷桑葉柴胡（辛涼）	多辛	辛溫治風寒、辛涼治風熱；中病即止

分類	功效	代表藥	性味	要點
清熱藥	清解裡熱	石膏知母梔子；黃芩黃連黃柏；金銀花連翹	多苦寒	分清熱瀉火、涼血、燥濕、解毒、清虛熱
瀉下藥	通導大便	大黃芒硝（攻下）；火麻仁（潤下）	苦寒或甘潤	攻下慎用於虛人；潤下宜老年津枯
祛風濕藥	祛風散寒除濕	獨活威靈仙防己木瓜	辛苦溫	痹證要藥；多溫燥傷陰，陰虛慎用
化濕藥	芳香化濁	藿香蒼朮厚朴砂仁	芳香溫燥	濕濁中阻要藥；砂仁兼安胎
利水滲濕藥	通利水道	茯苓豬苓澤瀉薏苡仁茵陳	甘淡	茵陳為黃疸要藥；薏苡仁兼健脾
溫裡藥	溫中回陽	附子乾薑肉桂吳茱萸	辛熱	附子回陽救逆第一品，須先煎去毒
理氣藥	行氣解鬱	陳皮枳實木香香附	辛苦溫	香附為氣病之總司、女科之主帥
消食藥	消化食積	山楂神曲麥芽萊菔子	甘平	山楂消肉積、麥芽消米麵、萊菔子消痰食
止血藥	制止出血	三七茜草蒲黃白及仙鶴草	多澀或苦	三七止血不留瘀；白及斂瘡生肌
活血化瘀藥	通行血脈	川芎丹參紅桃仁牛膝	辛苦溫	川芎為血中之氣藥；丹參一味功同四物
化痰止咳平喘	化痰降氣	半夏貝母桔梗杏仁蘇子	辛或苦	半夏燥濕化痰、貝母清熱化痰，寒熱有別
安神藥	安定神志	酸棗仁柏子仁遠志龍骨	甘平或重鎮	養心安神與重鎮安神兩路
平肝息風藥	平抑肝陽息風止痙	天麻鉤藤羚羊角全蠍	多入肝經	天麻為眩暈要藥；全蠍蜈蚣搜風通絡
補虛藥	補益虛損	人參黃芪白朮（氣）；當歸熟地阿膠（血）；麥冬百合（陰）；鹿茸杜仲（陽）	甘	補氣補血補陰補陽四路；虛不受補先調脾胃

配伍・禁忌	內容	系統檢核行為
七情配伍	相須相使增效；相畏相殺減毒；相惡相反為忌	組方時自動標注藥對關係，相反者攔截
十八反	烏頭反半夏瓜蔞貝母白及白蘞；甘草反海藻大戟甘遂芫花；藜蘆反諸參辛芍	S5 出方前逐對掃描，命中即紅燈
十九畏	硫磺畏朴硝；水銀畏砒霜；狼毒畏密陀僧；巴豆畏牽牛；丁香畏鬱金…	同上；命中須醫師書面確認例外
妊娠禁忌	禁用：水蛭虻蟲巴豆牽牛麝香…；慎用：桃仁紅大黃枳實肉桂…	孕產婦通道強制啟用，禁用藥直接攔截

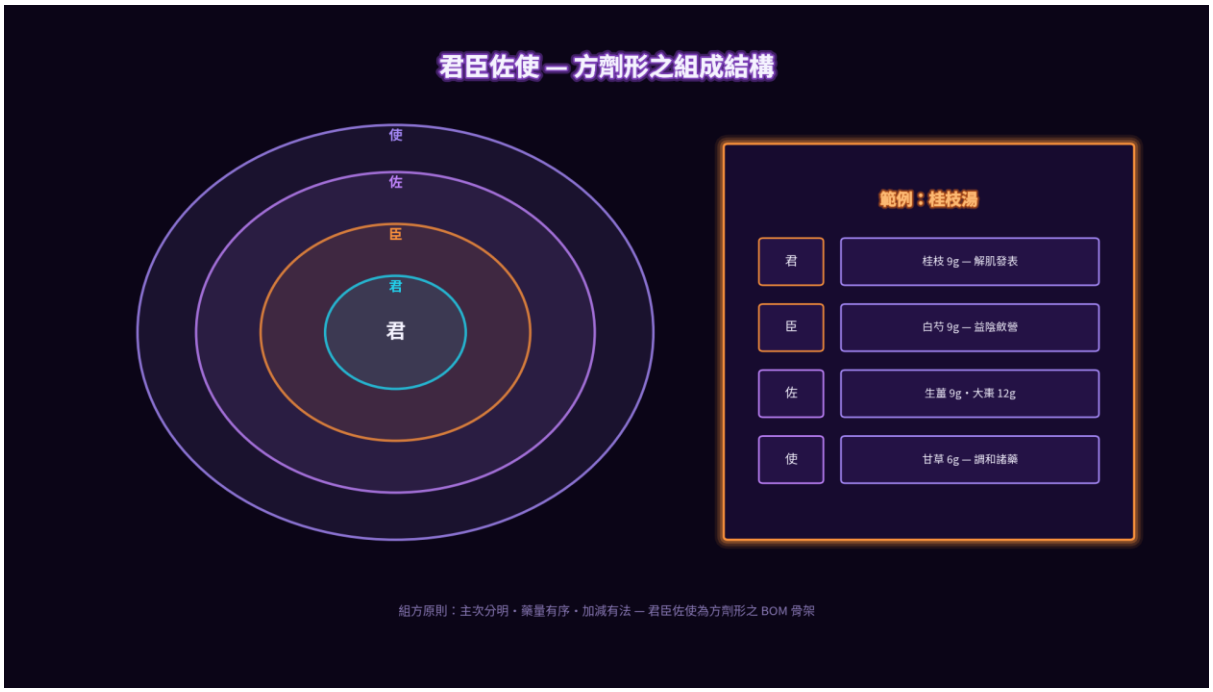
◆ 常用藥對（配伍精華）

藥對	配伍意義	常見出處
麻黃・桂枝	相須發汗解表，治太陽傷寒	麻黃湯
桂枝・白芍	一散一收調和營衛	桂枝湯
石膏・知母	相須清氣分大熱	白虎湯
柴胡・黃芩	和解少陽基本對	小柴胡湯
人參・黃芪	相須大補脾肺之氣	補中益氣湯
當歸・川芎	養血活血行氣止痛	四物湯
半夏・陳皮	燥濕化痰理氣和中	二陳湯
黃連・吳茱萸	辛開苦降治肝火犯胃	左金丸
黃連・肉桂	交通心腎治心腎不交	交泰丸
金銀花・連翹	清熱解毒疏散風熱	銀翹散
桃仁・紅	活血祛瘀止痛	桃紅四物湯
乳香・沒藥	活血行氣止痛生肌	活絡效靈丹
三稜・莪朮	破血行氣消積止痛	三稜丸
酸棗仁・柏子仁	養心安神治失眠心悸	天王補心丹

藥對	配伍意義	常見出處
龍骨・牡蠣	重鎮安神收斂固澀	桂枝加龍骨牡蠣湯
天麻・鉤藤	平肝息風治眩暈抽搐	天麻鉤藤飲
全蠍・蜈蚣	搜風通絡止痙止痛	止痙散
砂仁・厚朴	化濕行氣醒脾和胃	平胃散加減
枳實・白朮	消痞健脾治脾虛氣滯	枳朮丸
黃芪・防風	益氣固表止汗防感	玉屏風散
乾薑・細辛・五味子	溫肺化飲斂肺止咳	小青龍湯
芍藥・甘草	緩急止痛（酸甘化陰）	芍藥甘草湯

4.5　方劑學：方劑形的組成學

方劑是中醫治療的主力載體。組方原則為君臣佐使：君藥針對主證，臣藥輔君加強，佐藥佐助佐制或反佐，使藥引經調和。方劑的變化有三式——藥味加減（隨證化裁）、藥量增減（改變主治重心）、劑型更換（湯者蕩也、丸者緩也、散者散也）。



【圖】君臣佐使：方劑形之組成結構與桂枝湯範例

分類	代表方	組成（節錄）	功效	主治
解表劑	桂枝湯	桂枝芍藥生薑大棗甘草	解肌發表調和營衛	太陽中風表虛證
解表劑	麻黃湯	麻黃桂枝杏仁甘草	發汗解表宣肺平喘	太陽傷寒表實證
解表劑	銀翹散	金銀花連翹桔梗薄荷竹葉	辛涼透表清熱解毒	溫病初起衛分證
和解劑	小柴胡湯	柴胡黃芩半夏人參甘草	和解少陽	少陽病往來寒熱
和解劑	逍遙散	柴胡當歸白芍白朮茯苓	疏肝解鬱健脾養血	肝鬱血虛脾弱證
清熱劑	白虎湯	石膏知母粳米甘草	清氣分大熱	陽明經證四大症
清熱劑	龍膽瀉肝湯	龍膽草黃芩梔子澤瀉車前子	瀉肝膽實火清下焦濕熱	肝火上炎肝膽濕熱
溫裡劑	理中丸	人參乾薑白朮甘草	溫中散寒健脾	太陰虛寒脾胃虛寒
溫裡劑	四逆湯	附子乾薑甘草	回陽救逆	少陰寒化亡陽證
補益劑	四君子湯	人參白朮茯苓甘草	益氣健脾	脾胃氣虛證
補益劑	四物湯	當歸川芎白芍熟地	補血調血	血虛血滯諸證
補益劑	六味地黃丸	熟地山萸肉山藥澤瀉茯苓丹皮	滋陰補腎	腎陰虛證
補益劑	歸脾湯	人參黃芪白朮當歸龍眼肉酸棗仁	益氣補血健脾養心	心脾兩虛證
理氣劑	半夏厚朴湯	半夏厚朴茯苓生薑蘇葉	行氣散結降逆化痰	梅核氣痰氣鬱結
理血劑	血府逐瘀湯	桃仁紅當歸川芎柴胡枳殼	活血化瘀行氣止痛	胸中血瘀證
治風劑	川芎茶調散	川芎荊芥防風細辛白芷	疏風止痛	外感風邪頭痛
祛濕劑	平胃散	蒼朮厚朴陳皮甘草	燥濕運脾行氣和胃	濕滯脾胃
祛濕劑	獨活寄生湯	獨活桑寄生杜仲牛膝細辛	祛風濕止痹痛補肝腎益氣血	痹證日久肝腎兩虛
祛痰劑	二陳湯	半夏陳皮茯苓甘草	燥濕化痰理氣和中	濕痰證
消導劑	保和丸	山楂神曲萊菔子半夏陳皮	消食和胃	食積停滯
安神劑	天王補心丹	生地天冬麥冬酸棗仁柏子仁	滋陰清熱養血安神	陰虛血少神志不安
固澀劑	玉屏風散	黃芪白朮防風	益氣固表止汗	表虛自汗易感風邪
固澀劑	四神丸	補骨脂肉豆蔻五味子吳茱萸	溫腎暖脾澀腸止瀉	五更洩瀉

分類	代表方	組成（節錄）	功效	主治
開竅劑	安宮牛黃丸	牛黃麝香犀角鬱金黃連	清熱開竅豁痰解毒	熱入心包神昏譫語

方證對應是主線

系統組方的主線是「方證對應」——由證型形直達方劑形（太陽中風→桂枝湯），而非自由組合藥味。經方為骨架、時方為擴充、自組方為例外：自組方須給出「為何不用成方」的理由並接受更高一級檢核。

◆ 方劑加減變化示例（桂枝湯法）

兼證 / 變化	加減	出處依據
項背強几几	加葛根 12g	桂枝加葛根湯
喘咳	加厚朴、杏仁	桂枝加厚朴杏子湯
汗漏不止、惡風	加附子溫經固表	桂枝加附子湯
脈促胸滿	去芍藥	桂枝去芍藥湯
腹滿時痛	倍芍藥加飴糖	小建中湯法
心悸、煩躁	加龍骨、牡蠣	桂枝加龍骨牡蠣湯

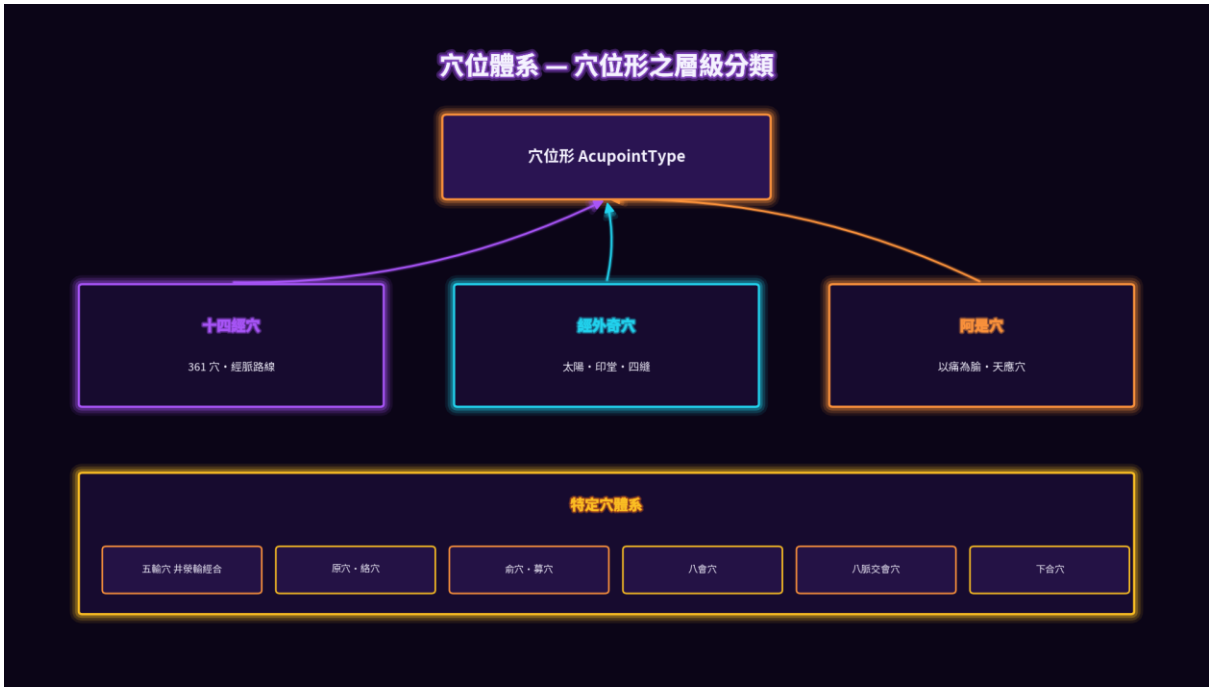
◆ 十劑與方劑功效分類

十劑	功效	代表藥 / 方
宣劑	湧吐宣壅	瓜蒂散、桔梗
通劑	通行氣血水濕	木通、防己、五苓散
補劑	補益虛損	四君子湯、六味地黃丸
洩劑	瀉下去實	大承氣湯、葶藶子
輕劑	解表發散	麻黃湯、銀翹散
重劑	重鎮安神	朱砂安神丸、磁石
滑劑	潤燥滑利	麻子仁丸、蜂蜜

十劑	功效	代表藥 / 方
澀劑	收斂固脫	玉屏風散、四神丸
燥劑	燥濕化痰	二陳湯、平胃散
濕劑	滋陰潤燥	百合固金湯、麥冬

4.6 針灸經絡學

經絡形與穴位形構成針灸知識體系。十二正經依流注次序相接（肺→大腸→胃→脾→心→小腸→膀胱→腎→心包→三焦→膽→肝→肺），任督二脈統攝前後。特定穴體系是取穴的精華：五輸穴（井滎輸經合）依「所出為井、所溜為滎、所注為輸、所行為經、所入為合」配五行補瀉；原穴調臟腑原氣；俞穴募穴治臟腑病；八會穴治特定組織病；八脈交會穴通奇經；下合穴治六腑病。



【圖】穴位體系：穴位形之層級分類與特定穴

常見病證	治則	主穴（節錄）	配穴與加減
頭痛（外感）	疏風通絡止痛	百會太陽風池合谷	太陽經痛加後溪；陽明加印堂內庭；少陽加外關足臨泣
胃脘痛	和胃止痛	中脘足三里內關公孫	寒證加灸；肝氣犯胃加太沖；食滯加下脘梁門

常見病證	治則	主穴（節錄）	配穴與加減
腰痛	補腎強腰通絡	腎俞委中夾脊阿是穴	寒濕加灸關元；瘀血加膈俞；腎虛加太溪
不寐	寧心安神	神門百會安眠三陰交	心脾兩虛加心俞脾俞；肝火加太沖行間
中風（中經絡）	醒腦開竅疏通經絡	內關水溝三陰交極泉尺澤委中	上肢不遂加肩髃曲池；口眼歪斜加地倉頰車
面癱（口僻）	祛風通絡疏調經筋	翳風地倉頰車合谷太沖	急性期輕刺；恢復期加足三里補氣
痛經（實證）	行氣散寒化瘀止痛	中極次髎三陰交地機	寒凝加關元灸；氣滯加太沖

刺灸法要點：補瀉手法（提插補瀉、捻轉補瀉、迎隨補瀉）依虛實而施；灸法（艾炷灸、艾條灸、溫針灸）宜寒證虛證；刺灸禁忌須內建——小兒囟門、孕婦腰骶與三陰交合谷等禁刺部位、飢飽疲勞醉酒暫緩、有出血傾向慎刺。

◆ 五輸穴・八脈交會穴體系

特定穴	內容	配屬 / 配伍	應用要點
五輸穴	井滎輸經合（所出所溜所注所行所入）	陰井木、陽井金之五行配屬	「滎輸治外經、合治內腑」；虛則補其母、實則瀉其子
原穴	十二原：臟腑原氣留止之處	合谷・太沖・太溪・神門・衝陽…	臟腑病取原穴；四關穴（合谷太沖）調氣血
絡穴	十五絡脈別出之處	列缺・內關・豐隆・公孫…	表裡兩經同病取絡穴；長針久留
俞穴・募穴	背俞（陽）・腹募（陰）	肺俞中脘、心俞巨闕…	「陰病引陽、陽病引陰」；俞募配穴治臟腑病
八會穴	臟會中脘、腑會中脘、氣會膻中、血會膈俞、筋會陽陵泉、脈會太淵、骨會大杼、髓會絕骨	各會穴主治相應組織病	血證取膈俞、筋病取陽陵泉

特定穴	內容	配屬 / 配伍	應用要點
八脈交會穴	公孫內關（胃心胸）、臨泣外關（目外眥頸耳肩）、後溪申脈（目內眥頸項耳肩）、列缺照海（肺系咽喉胸膈）	上下肢配穴	按病位所在配對取穴
下合穴	胃三里、大腸上巨虛、小腸下巨虛、膀胱委中、膽陽陵泉、三焦委陽	六腑病取下合穴	「合治內腑」，《內經》古法

4.7 養生治未病：體質形與養生形

《素問·四氣調神大論》「聖人不治已病治未病」是中醫養生的總綱。系統以體質形為個體化底座，九種體質辨識（王琦九分法）決定養生方向，養生形承載四季、食療、起居、情志方案。



【圖】九種體質辨識：體質形與治未病

體質	特徵	易感傾向	調理原則
平和質	精力充沛面色潤澤體態勻稱	較少	飲食有節起居有常，維持平衡
氣虛質	氣短懶言易疲乏易感冒	反覆感冒、內臟下垂	補氣健脾：黃芪山藥大棗；忌耗氣
陽虛質	畏寒肢冷喜熱飲食	水腫洩瀉、陽痿宮寒	溫陽散寒：羊肉生薑韭菜；忌生冷

體質	特徵	易感傾向	調理原則
陰虛質	口燥咽乾手足心熱失眠	虛火上炎、乾燥病證	滋陰潤燥：百合銀耳芝麻；忌辛辣
痰濕質	體肥腹滿口黏苔膩	三高、中風、多囊	健脾化濕：薏米陳皮冬瓜；忌肥甘
濕熱質	面垢油光口苦苔黃膩	瘡瘍黃疸、泌尿感染	清熱利濕：綠豆苦瓜薏米；忌酒熱
血瘀質	面色晦暗易生色斑刺痛	痛經、血栓、腫瘤	活血行氣：山楂醋玫瑰；忌寒凝
氣鬱質	神情抑鬱善太息胸脅脹	鬱證、梅核氣、甲狀腺	疏肝理氣：玫瑰花佛手；多運動
特稟質	過敏體質遺傳傾向	哮喘蕁麻疹過敏性鼻炎	益氣固表避過敏原：黃芪防風；忌發物

季節	養生要旨	飲食要點	起居運動
春	生發養肝、夜臥早起	省酸增甘以養脾氣（少酸多甘）	廣步於庭舒展筋骨、條暢情志
夏	養長養心、夜臥早起	省苦增辛以養肺氣；適食酸收	無厭於日適度汗出、忌過用空調
秋	收斂養肺、早臥早起	省辛增酸以養肝氣；潤燥生津	安寧神志、防秋燥傷肺
冬	閉藏養腎、早臥晚起	省鹹增苦以養心氣；溫補潛陽	避寒就溫、勿擾陽氣、適度冬練

◆ 食療常見方案（養生形範例）

體質／狀態	食療方案	要點
氣虛質	黃芪山藥大棗粥、黨參燉雞	補氣而不壅滯，佐陳皮理氣
陽虛質	當歸生薑羊肉湯、韭菜核桃粥	溫陽散寒；嚴忌生冷
陰虛質	百合銀耳羹、麥冬枸杞茶、桑椹膏	滋陰潤燥；忌辛辣香燥
痰濕質	薏米赤小豆粥、荷葉冬瓜湯、陳皮普洱	健脾化濕；忌肥甘厚味
濕熱質	綠豆百合湯、苦瓜薏米粥、玉米須茶	清熱利濕；嚴戒酒
血瘀質	山楂玫瑰茶、黑木耳、醋泡黑豆	活血不傷正；孕期忌用活血食材
氣鬱質	玫瑰花茶、佛手柑粥、小麥甘草大棗湯	疏肝理氣安神
病後調理	四神湯（山藥蓮子芡實茯苓）、小米紅棗粥	健脾益氣助運化，虛不受補首選

4.8 專科知識：專科形的臨床覆蓋

專科形繼承通科辨證骨架，疊加專科特有規律：婦科以沖任督帶與月經週期為軸，兒科須知「啞科」以望診為先、臟腑嬌嫩易虛易實，骨傷以筋骨並重內外兼治為則，五官以經絡分部為要。



【圖】專科分科：專科形之臨床覆蓋

專科	常見病	核心證型	代表治法方	專科要點
內科	感冒・咳嗽・心悸・不寐・胃脘痛・消渴・眩暈・中風	風寒束表、心脾兩虛、肝陽上亢、痰瘀阻絡	麻黃湯、歸脾湯、天麻鉤藤飲、補陽還五湯	內科為全科之基，臟腑辨證為主軸
婦科	月經先後期・痛經・閉經・崩漏・帶下・惡阻・缺乳	氣滯血瘀、氣血兩虛、腎虛、濕熱下注	逍遙散、四物湯、完帶湯、下乳湧泉散	調經以「補腎-疏肝-健脾」為三法；孕期用藥有禁忌層級
兒科	肺炎喘嗽・泄瀉・厭食・疳積・驚風・遺尿	風熱閉肺、脾虛洩瀉、食積疳積、脾腎氣虛	麻杏石甘湯、參苓白朮散、肥兒丸	啞科望診為先；藥量按體重年齡折算；推拿捏脊常為首選
骨傷	頸椎病・腰突・骨折筋傷・痹證	氣滯血瘀、風寒濕痹、肝腎不足	身痛逐瘀湯、獨活寄生湯、補腎壯筋湯	筋骨並重、內外兼治、動靜結合；三期用藥（攻瘀-續骨-補腎）

專科	常見病	核心證型	代表治法方	專科要點
五官	針眼・耳鳴耳聾・鼻淵・喉痹・目赤	風熱上攻、肝火上炎、腎精虧虛、肺經鬱熱	銀翹散、龍膽瀉肝湯、耳聾左慈丸、蒼耳子散	循經分部：目屬肝、耳屬腎、鼻屬肺、咽喉屬肺胃
皮膚	濕瘡・癮疹・痤瘡・蛇串瘡・脫髮	濕熱浸淫、風邪襲表、血熱、肝鬱血瘀	龍膽瀉肝湯、消風散、枇杷清肺飲、桃紅四物湯	「治外必本諸內」；血虛風燥為慢性瘙癢共性

◆ 婦科月經病辨證提要

病證	常見證型	辨證要點	代表方
月經先期	血熱（實熱/虛熱/肝鬱）、氣虛	量色質＋兼症；先期量多色紅屬熱	清經散、丹梔逍遙散、歸脾湯
月經後期	血寒（實寒/虛寒）、血虛、氣滯	後期量少色黯有塊屬寒	溫經湯、大補元煎、烏藥湯
痛經	氣滯血瘀、寒凝血瘀、濕熱蘊結、氣血虛弱、腎氣虧虛	痛的時間（經前/經中/經後）、拒按喜按	膈下逐瘀湯、少腹逐瘀湯、清熱調血湯、聖愈湯
閉經	氣血虛弱、腎氣虧虛、陰虛血燥、氣滯血瘀、痰濕阻滯	虛實之分；原發繼發	人參養榮湯、加減葳蕤菟絲子、血府逐瘀湯
崩漏	血熱、腎虛、脾虛、血瘀	崩中漏下之別；塞流澄源復舊三法	清熱固經湯、固本止崩湯、逐瘀止血湯
帶下病	脾虛、腎陽虛、陰虛夾濕、濕熱下注、熱毒蘊結	帶下量色質味	完帶湯、內補丸、知柏地黃丸、止帶方

◆ 兒科要點補充

病證	要點	代表治法
肺炎喘嗽	風寒閉肺/風熱閉肺/痰熱閉肺/毒熱閉肺/心陽虛衰	宣肺開閉為總則；麻杏石甘湯為主方；危候防心陽虛衰
小兒泄瀉	常證（風寒/濕熱/傷食/脾虛/脾腎陽虛）；變證（傷陰/傷陽/陰陽兩傷）	運脾化濕為主；防脫水傷陰傷陽為要

病證	要點	代表治法
疳積	疳氣（輕）→疳積（中）→乾疳（重）	健運脾胃為主；肥兒丸；配合捏脊刺四縫
驚風	急驚風（感受時邪/暴受驚恐/痰熱積滯）；慢驚風（脾虛肝旺/脾腎陽虛）	急驚先開竅息風；慢驚溫補脾腎
五遲五軟	肝腎不足、心脾兩虛	補腎養肝健脾；六味地黃丸加減
小兒用藥特點	藥量按體重年齡折算；中病即止；慎用大苦大寒大辛大熱	推拿捏脊常為首選輔助；劑量分次服

◆ 內科常見病辨證提要

病證	常見證型	辨證要點	代表方
感冒	風寒束表、風熱犯表、暑濕傷表、氣虛感冒	寒熱偏重、汗出有無、脈浮緊或浮數	荊防敗毒散、銀翹散、新加香薷散、參蘇飲
咳嗽	風寒襲肺、風熱犯肺、燥邪傷肺、痰濕蘊肺、肝火犯肺、肺陰虧虛	痰色質、發病急緩、與情志關係	三拗湯、桑菊飲、桑杏湯、二陳湯、瀉白散、沙參麥冬湯
心悸	心虛膽怯、心血不足、心陽不振、水飲凌心、心血瘀阻	悸動誘因、伴隨症狀、舌脈	安神定志丸、歸脾湯、桂枝甘草龍骨牡蠣湯、苓桂朮甘湯、桃仁紅花煎
不寐	肝火擾心、痰熱擾心、心脾兩虛、心腎不交、心膽氣虛	入睡難易、多夢、兼症	龍膽瀉肝湯、黃連溫膽湯、歸脾湯、黃連阿膠湯、安神定志丸
胃脘痛	寒邪客胃、飲食停滯、肝氣犯胃、肝胃鬱熱、瘀血停胃、胃陰虧虛、脾胃虛寒	痛勢喜按拒按、與飲食情志關係	良附丸、保和丸、柴胡疏肝散、化肝煎、失笑散、一貫煎、黃芪建中湯
泄瀉	寒濕內盛、濕熱傷中、食滯腸胃、脾胃虛弱、腎陽虛衰	瀉下勢緩勢急、五更、腹痛特點	藿香正氣散、葛根芩連湯、保和丸、參苓白朮散、四神丸
眩暈	肝陽上亢、氣血虧虛、腎精不足、痰濕中阻	虛實之分、與體位情志關係	天麻鉤藤飲、歸脾湯、左歸丸、半夏白朮天麻湯

病證	常見證型	辨證要點	代表方
中風（中經絡）	風痰入絡、風陽上擾、陰虛風動	半身不遂口眼歪斜之有無、神志	真方白丸子、天麻鉤藤飲、鎮肝息風湯
消渴	上消肺熱津傷、中消胃熱熾盛、下消腎陰虧虛、陰陽兩虛	多飲多食多尿偏重	消渴方、玉女煎、六味地黃丸、金匱腎氣丸
痹證	風寒濕痹（行痹痛痹著痹）、風濕熱痹、痰瘀痹阻、肝腎兩虛	痛之游走固定重著、紅熱有無	防風湯、烏頭湯、薏苡仁湯、白虎加桂枝湯、獨活寄生湯

4.9　經典典籍：典籍形的知識源流

典籍形為一切知識提供出處錨點。系統要求：凡引經典條文，必標注書名篇章；凡用經方，必可回溯至原始條文。這既是形證據鏈的文獻端點，也是防範 LLM 幻覺的最後防線。



【圖】中醫典籍時間軸：典籍形之知識源流

典籍	時代・作者	核心貢獻	系統應用方式
《黃帝內經》	戰國至西漢・集體	陰陽五行、藏象經絡、病因病機、治則養生之奠基	理論判定的最高依據；條文式檢索
《難經》	東漢・傳扁鵲	脈學、奇經八脈、命門三焦發揮	脈診與奇經辨證補充依據

典籍	時代・作者	核心貢獻	系統應用方式
《傷寒雜病論》	東漢・張仲景	六經辨證、方證對應、經方體系之祖	六經辨證判準來源；經方主幹
《神農本草經》	東漢・集體	四氣五味、有毒無毒、上中下三品分類	本草形屬性的原始定義源
《脈經》	西晉・王叔和	二十四脈規範化、脈診體系化	脈形屬性值的標準詞表
《針灸甲乙經》	西晉・皇甫謐	腧穴定位與主治體系化	穴位形定位屬性的權威來源
《諸病源候論》	隋・巢元方	病因病機證候學巨著	症狀形與病機關係的證候庫
《千金要方》	唐・孫思邈	百科式臨床、醫德規範、婦兒專科	專科知識與養生形來源
《太平惠民和劑局方》	宋・官修	成方規範、劑型標準	方劑形的官方規格參考
《小兒藥證直訣》	宋・錢乙	兒科辨證體系、六味地黃丸	兒科形與臟腑補瀉範式
《脾胃論》	金・李東垣	內傷脾胃學說、補中益氣湯	脾胃證型族與補土派依據
《丹溪心法》	元・朱丹溪	滋陰降火、痰瘀致病說	陰虛痰瘀證型依據
《景岳全書》	明・張介賓	命門學說、溫補體系、八陣分類	溫補派治法與方劑分類
《本草綱目》	明・李時珍	本草集大成、1892 味藥	本草形屬性值的擴充主庫
《溫病條辨》	清・吳鞠通	三焦辨證、衛氣營血實踐、銀翹散	溫病體系判準與代表方
《醫林改錯》	清・王清任	瘀血學說、血府逐瘀湯	血瘀證型與活血治法
《醫學衷中參西錄》	近代・張錫純	中西匯通、藥理實踐	近代過渡知識與實證參考

檢索策略採「先經後案再研」的時間序列：先查經典原文（最高權威），再查名醫醫案（實踐證據），後查近代研究（統計證據）。三層證據衝突時，以經典定方向、以醫案定可行性、以研究定強度，並在輸出中顯式標注三層的一致程度。

◆ 經典原文引用示例（形證據鏈之文獻端點）

主題	原文（節錄）	出處
治病求本	陰陽者，天地之道也……治病必求於本	《素問・陰陽應象大論》

主題	原文（節錄）	出處
正氣存內	正氣存內，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛	《素問．刺法論》/《評熱病論》
辨證論治	觀其脈證，知犯何逆，隨證治之	《傷寒論》第 16 條
太陽中風	太陽病，發熱，汗出，惡風，脈緩者，名為中風	《傷寒論》第 2 條
太陽傷寒	太陽病，或已發熱，或未發熱，必惡寒，體痛，嘔逆，脈陰陽俱緊者，名為傷寒	《傷寒論》第 3 條
治未病	聖人不治已病治未病，不治已亂治未亂	《素問．四氣調神大論》
溫病衛分	太陰之為病，脈不緩不緊而動數……	《溫病條辨》上焦篇
用藥如用兵	藥之治病，猶兵之戡亂也……	《用藥如用兵論》（徐大椿）
醫德規範	凡大醫治病，必當安神定志，無欲無求，先發大慈惻隱之心	《備急千金要方．大醫精誠》

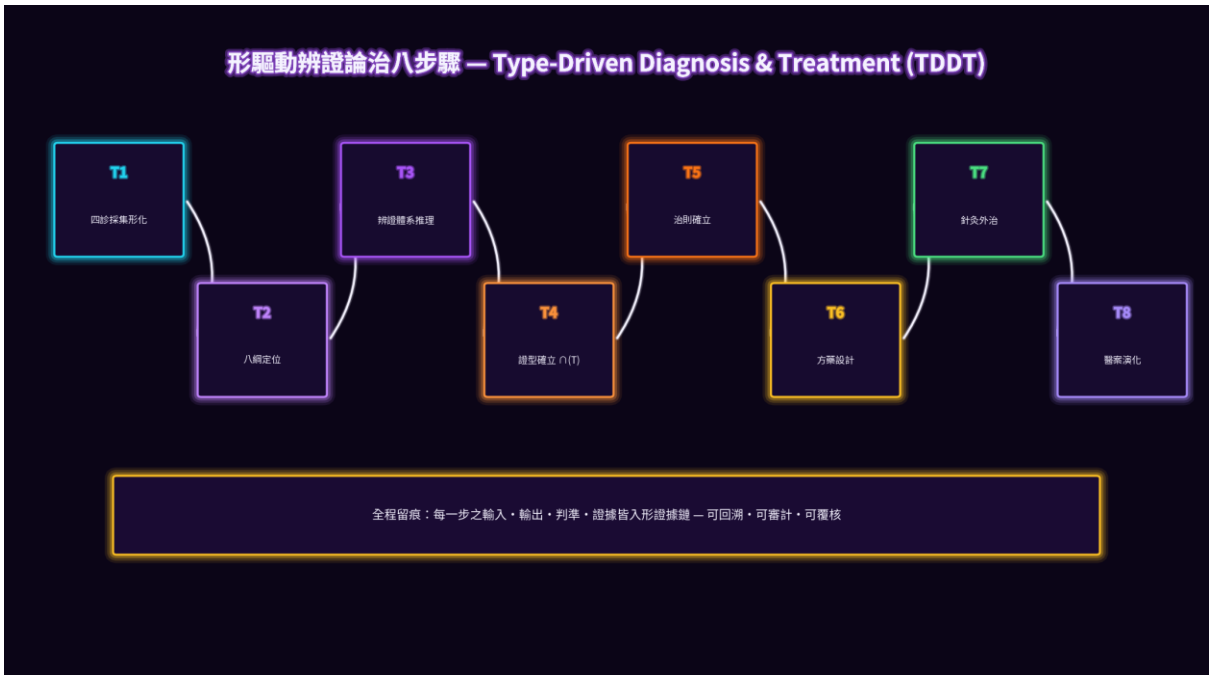
引用紀律

凡引經典必標注書名篇章；引文須逐字核對原文，禁止半文半白之改寫；同一條文在不同版本有異文時標注版本——這是防範 LLM 幻覺在文獻端的第一道閘門。

第 5 章　形驅動辨證論治八步驟 TDDT

TDDT（Type-Driven Diagnosis & Treatment）是 AI 中醫大腦的操作骨架。它把辨證論治拆解為八個形驅動步驟，每步都遵循「形定義→屬性填值→關係連邊→判準檢核」的框架，並在步驟之間以規格化中間產物交接。本章給出八步驟的完整規範；第 6 章則把每一步翻譯為可直接使用的提示詞工作流。

5.1　TDDT 總覽與步驟銜接



【圖】形驅動辨證論治八步驟：輸入・輸出・判準全程留痕

八步驟分屬三個階段：資訊階段（T1–T2）把原始四診資訊形化並完成八綱定位；辨證階段（T3–T4）展開辨證體系推演並以 ∩(T) 立證；治療階段（T5–T7）完成立法、處方、針灸外治；T8 為閉環階段，負責醫案沉澱與演化。步驟之間的銜接契約是「形實例」：上一步的輸出形，就是下一步的輸入形，任何未形化的自由文本都不能跨步傳遞。

5.2 T1–T8 步驟規範

步驟	輸入	核心操作	輸出	判準
T1 四診採集形化	主訴・現病史・望聞問切原始描述	按四診綱目結構化為症狀形・舌形・脈形；缺失顯式標注	四診屬性表 + 缺口清單	完整性；不臆造體徵；術語規範
T2 八綱定位	四診屬性表	表裡寒熱虛實陰陽逐綱判定並列證據；夾雜顯式標注	八綱定位表 + 假設清單	每綱有據；矛盾顯式；陰陽總綱一致
T3 辨證體系推理	八綱定位 + 四診表	依病種啟用臟腑 / 六經 / 衛氣營血 / 三焦 / 經絡體系並行推演	候選證型排名 + ∩(T) 吻合度	體系選擇有據；≥2 候選比較
T4 證型確立 ∩(T)	候選證型集	主證型判定、鑑別診斷、兼證夾雜整理	證型形實例 + 鑑別表	∩(T) ≥ 0.85；反證已排除
T5 治則確立	證型形實例	標本緩急排序、八法選定、兼證立法	治則形 + 治法形組合	證→法推導鏈完整；禁忌反向檢核
T6 方藥設計	治法組合 + 體質禁忌	方證對應選方、君臣佐使組成、劑量煎服法、加減	方劑形 BOM + 加減備案	配伍禁忌全檢；每味藥有治法指歸
T7 針灸外治	證型 + 經絡病位	循經 + 局部 + 特定穴配伍；補瀉手法；療程	穴位形處方 + 療程表	取穴有經絡依據；刺灸禁忌檢核
T8 醫案演化	全程形證據鏈 + 療效	醫案入庫、規律萃取、判準精進提案	病案形 + 演化提案	一般化不越界；審核閘門留痕

表中判準欄即各步的「出關條件」——不滿足者不得流入下一步。TDDT 對傳統「理法方藥」的增益在於：每步之間的中間產物都可獨立審查，錯誤在對應步驟即可攔截，不會一路傳導到處方才爆發。

5.3 全程留痕與形證據鏈

形證據鏈是 TDDT 的時間戳記化存證：每一步的輸入快照、提示詞版本、輸出形實例、判準計算結果、醫師覆核簽署，依序封存為鏈式結構。它支撐三件事：其一，可回溯——任何一張處方都

能一路回溯到四診原始記錄；其二，可審計——醫療爭議與合規審查有完整證據；其三，可複現——同一醫案以同一版本判準重放，結果一致。

鏈節	存證內容	時間語義
T1–T2 節點	四診快照、八綱判定與證據指標	就診時刻的患者狀態
T3–T4 節點	候選證型、∩(T) 計算過程、鑑別排除理由	推理時刻的判斷依據
T5–T7 節點	治法推導、處方 BOM、針灸方案、禁忌檢核報告	治療決策時刻的完整意圖
T8 節點	療效結局、前後對照、演化提案與審核結果	閉環時刻的經驗沉澱

第 6 章　準確使用方法提示詞手冊 S1–S8

本章是全書的核心使用手冊：把 TDDT 八步驟翻譯為八個可直接貼用的提示詞工作流（S1–S8），每個工作流給出定位、輸入規格、完整提示詞模板、輸出規格、∩(T) 檢核表與實戰範例。使用者在 Mind AI 平台上，按序啟用八個工作流，即可完成一次全程受檢核的辨證論治。

6.0　使用方法總則

◆ 在 Mind AI 上啟用工作流的標準動作

- 第一步「定角色」：新會話開始即貼用該工作流的角色設定段，明確告知系統以中醫輔助角色運作、以形化格式輸出；
- 第二步「給規格」：依輸入規格表準備材料，按模板佔位符填入；缺項寧可標注「未採集」，不可編造；
- 第三步「收輸出」：對照輸出規格表驗收，檢查 ∩(T) 檢核表逐項通過後才進入下一工作流；
- 第四步「留痕」：保存輸入輸出全文（即形證據鏈節點），並記錄所用判準版本；
- 第五步「覆核」：涉及診斷與處方的工作流（S3–S6）輸出一律須執業中醫師覆核簽署後方可採用。

規則	內容	理由
逐步交付	一次會話只走一個 S 工作流，產出驗收後再開下一步	避免上下文污染與檢核跳步
形化輸出	所有輸出以規格表的形格式呈現，拒絕自由散文	形實例才可檢核、可傳遞、可入庫
顯式缺口	缺失資訊標注「未採集」，不確定結論標注置信區間	空白臆想是醫療幻覺的主要來源
版本記錄	每次會話記錄判準版本與提示詞版本	可複現、可審計的前提
紅線攔截	S5 觸發十八反十九畏妊禁、S7 觸發危急警訊時立即停止並升級人工	安全優先於流程完成度

與一般 AI 問診的本質區別

一般用法是「把問題丟給 AI 要答案」；本手冊的用法是「讓 AI 在形規格裡作業，每步交卷給判準和醫師批改」。準確度不來自模型本身，而來自流程的檢核密度——這是「準確使用方法」四個字的真正含義。

◆ 依病種的工作流組合策略

病種	工作流序列	辨證體系重心	檢核重點
外感急性病	S1→S2→S3（六經/溫病）→S4→S5（可加 S6）→S7	六經或衛氣營血三焦	傳變時機；汗法下法禁忌；療程節奏加密
內傷慢性病	S1→S2→S3（臟腑）→S4→S5→S6→S7→S8	臟腑辨證＋氣血津液	標本緩急；虛實夾雜；長期用藥安全
婦科病	S1（加經帶胎產）→S2→S3（臟腑＋沖任）→S4→S5→S7	臟腑辨證＋沖任督帶	妊娠禁忌強制啟用；經期用藥時機
兒科病	S1（望診為重）→S2→S3（臟腑）→S4→S5（劑量折算）→S7	臟腑辨證（啞科）	劑量折算；推拿捏脊備選；病情變化快
筋骨傷科	S1→S2→S3（經絡＋臟腑）→S4→S5（內服）→S6（針灸外治）→S7	經絡辨證＋肝腎	三期用藥；外治禁忌；影像合參
養生調理	S1（體質採集）→S2（平和判定）→S7（階段評估）	體質辨識（非診療）	邊界紅線：疑似疾病即轉介

6.1 S1 四診採集官 — 資訊形化



【圖】S1 四診採集官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S1 是全流程的資訊入口：把患者主訴、現病史與望聞問切原始描述，結構化為症狀形・舌形・脈形清單。S1 的鐵律是「只記錄、不判斷」——辨證結論一律留給 S3，採集官一旦越權下判斷，就會把暗示性偏見寫進證據層，污染全鏈。

S1 提示詞模板（角色＋任務＋規格）

【角色】你是「四診採集官」，負責中醫四診資訊的結構化採集，只記錄不判斷。

【任務】將下列原始診療資訊逐項轉為四診結構化表：

1. 望診：望神（得神/失神/假神/神亂）、望色（青赤黃白黑）、望形態、望舌（舌色/舌形/舌態/苔色/苔質）、望小兒指紋。

2. 聞診：語聲、呼吸、咳嗽、嘔逆噯氣、體氣病室氣味。

3. 問診：依十問歌逐項——寒熱、汗、頭身、二便、飲食口味、胸腹、耳目、渴、舊病、病因，婦科加經帶胎產。

4. 切診：寸關尺脈象（位/數/形/勢/節律分候）、按診。

【規格】每項輸出：症狀形[名稱｜部位｜性質｜程度｜時間規律｜加劇緩解因素｜證據來源]。

【鐵律】① 未採集項目一律標注「未採集」，禁止補白、禁止推測；② 只用規範中醫術語，不寫同義模糊語；③ 不下任何辨證結論；④ 主訴原文完整保留於表頭。

輸入項	格式	示例
主訴	一句話 + 病程時間	惡寒發熱伴頭痛三天
現病史	起病、演變、已接受處理	三天前受涼後惡寒重、發熱輕、無汗、頭項強痛
四診原始描述	自然語言或問卷	面色偏白、苔薄白、脈浮緊有力、無咽痛口渴
既往史・用藥	簡列	既往體健；自行服用感冒藥兩日未緩解

∩(T) 檢核項	通過標準	未過處理
四診完整性	望聞問切四欄皆有明確填寫或「未採集」標注	列出缺口清單請醫師補採
不臆造體徵	所有體徵皆可回指原始描述	刪除無來源項目並標記異常
術語規範	症狀名稱符合中醫規範詞表	術語歸一化並保留原文

◆ 範例演練（外感案）

S1 範例輸入

主訴：惡寒發熱伴頭痛三天。

現病史：三天前淋雨受涼後惡寒重、發熱輕（T 37.8℃）、無汗、頭項強痛、鼻塞流清涕、咳嗽痰白清稀、口不渴、二便調。

四診：面色偏白、苔薄白、脈浮緊有力。既往體健。

S1 範例輸出（節錄）

症狀形清單：①惡寒｜全身｜冷感｜重度｜持續三天｜得溫不減｜主訴；②發熱｜全身｜T37.8℃｜輕度｜持續三天｜—｜現病史；③頭痛｜頭項部｜強痛｜中度｜持續｜遇風加重｜現病史；④無汗｜全身｜—｜—｜三天｜—｜現病史；⑤鼻塞流涕｜鼻｜清涕｜中度｜三天｜—｜現病史；⑥咳嗽｜肺系｜痰白清稀｜輕度｜三天｜—｜現病史；⑦口不渴｜口｜—｜—｜—｜—｜現病史。

舌形：淡紅舌薄白苔。脈形：浮（位）｜數平（數）｜—（形）｜有力（勢）｜齊（節律）｜寸關尺皆浮緊。

缺口清單：未採集——聞診氣息、按診、舊病細節。

使用要點：S1 輸出將直接作為 S2–S3 的證據層，其品質決定全鏈上限。實務上常見的失敗模式是

採集官偷跑辨證——例如把「惡寒重發熱輕」寫成「風寒表實」。凡在 S1 輸出看到證型詞彙，一律退回重做。

6.2 S2 八綱定位官 — 病位病性初判



【圖】S2 八綱定位官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S2 以四診屬性表為輸入，逐綱判定表裡、寒熱、虛實，並彙總陰陽。每綱判定必須附證據指標與反證檢查；出現夾雜（表寒裡熱、虛實夾雜）時並列呈現，不得強行簡化。

S2 提示詞模板

【角色】你是「八綱定位官」，負責病位病性的第一層判定，只做八綱，不做臟腑證型。

【任務】依四診屬性表逐綱判定並輸出定位表：

1. 表裡：表證（發熱惡寒並見、脈浮、病程短）/ 裡證（但寒但熱、臟腑症狀）/ 半表半裡（寒熱往來）。

2. 寒熱：寒（冷白稀潤靜：惡寒肢冷、面色白、痰涕清稀、口不渴、舌淡苔白、脈遲）/ 熱（紅黃乾稠動：發熱、面赤、痰涕稠黃、口渴、舌紅苔黃、脈數）。

3. 虛實：虛（久病、聲低、痛喜按、脈無力）/ 實（新病、聲高、痛拒按、脈有力）。

4. 陰陽：依表熱實 = 陽、裡寒虛 = 陰彙總。

【輸出】八綱定位表[綱｜判定｜支持證據（屬性值）｜反證檢查｜置信度高/中/低]。

【鐵律】① 每綱必附證據；② 矛盾證據顯式列出；③ 寒熱真假、虛實真假須專項鑑別並標注；④ 不出現任何臟腑證型結論。

∩(T) 檢核項	通過標準	常見偏差
證據支撐	每綱判定至少 2 項證據指標	憑單一症狀定綱
陰陽一致	陰陽總綱與六綱判定不矛盾	表寒實判陽卻總綱判陰之類邏輯錯
夾雜顯式	夾雜證並列呈現並標注轉化傾向	強行簡化為單一綱證
真假鑑別	疑似寒熱虛實真假時給出鑑別專項	忽略脈象舌象的關鍵鑑別價值

◆ 範例演練（續 S1 案）

S2 範例輸出

表裡｜表證｜支持：惡寒發熱並見、頭項強痛、脈浮、病程三天｜反證檢查：無裡證症狀｜置信度：高

寒熱｜寒證｜支持：惡寒重、痰白清稀、口不渴、苔薄白｜反證檢查：無熱象（T37.8℃ 屬微熱，與惡寒並見支持表寒）｜置信度：高

虛實｜實證｜支持：新病、脈浮緊有力、聲高｜反證檢查：無虛象｜置信度：高

陰陽｜陽證（表寒實）｜一致。寒熱真假：無徵象，不需鑑別。

假設清單：①表寒實證（主假設）；②待鑑別：表寒裡熱（需問口渴咽痛——現有「口不渴」已弱化此假設）。

6.3 S3 辨證推理官 — 體系推演



【圖】S3 辨證推理官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S3 是辨證的核心推理步驟：在八綱定位之上，啟用適當辨證體系（外感熱病用六經或衛氣營血三焦，內傷雜病用臟腑，經絡病變加經絡辨證），產出帶 ∩(T) 吻合度的候選證型排名。

S3 提示詞模板

【角色】你是「辨證推理官」，負責多體系辨證推演與候選證型排名。

【任務】依八綱定位表與四診屬性表執行：

1. 體系選擇：外感病→六經辨證（傷寒）或衛氣營血三焦（溫病）；內傷雜病→臟腑辨證；循經症狀→加經絡辨證。說明選擇理由。

2. 並行推演：候選證型 ≥ 2 個，逐一給出：判準集合 T（主證/次證/舌脈佐證/反證）、∩(T) 吻合度、支持證據、反對證據。

3. 傳變判斷：若病程有動態，給出傳變方向（六經/衛氣營血/三焦/臟腑乘侮）與時間證據。

4. 推薦主證型與次選證型，標注鑑別要點。

【輸出】候選證型排名表[證型｜判準集｜∩(T)｜支持/反對證據｜鑑別要點]。

【鐵律】① 禁止只給一個候選；② 吻合度按主證 3 分次證 2 分舌脈 2 分反證扣分計算；③ 六經與溫病體系不混用；④ 引用經典條文須標注篇章。

∩(T) 檢核項	通過標準
體系適配	體系選擇與病種（外感/內傷/經絡）相符並說明理由
多候選比較	≥ 2 候選證型逐一量化比較
吻合度可覆算	判準集與權重完整，讀者可自行覆算
傳變有時間證據	傳變結論附節點對照（何時出現何症）
經典可溯源	所引條文標注書名篇章

◆ 範例演練（續 S2 案）

S3 範例輸出（節錄）

體系選擇：六經辨證（傷寒）——理由：起病急、惡寒發熱並見、脈浮，屬外感傷寒範疇；無高熱口渴斑疹，不啟用溫病體系。

候選一：太陽傷寒證 | T={惡寒(3),無汗(3),頭項強痛(2),脈浮緊(3),苔薄白(2),發熱(2)} | 反證：無 | ∩(T)=0.94 | 支持：S1 全部證候；反對：無。

候選二：太陽中風證 | T={汗出(3),惡風(3),脈浮緩(3)} | ∩(T)=0.41 | 反證：「無汗」直接反對「汗出」，排除。

鑑別要點：傷寒與中風之別在汗出有無、脈緊與緩。

推薦：太陽傷寒證（主證型）。傳變預測：表寒不解可入裡化熱（陽明），或鬱熱於肺（麻杏石甘湯證）。

6.4 S4 治則確立法官 — 治法推導



【圖】S4 治則確立法官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S4 承上啟下：由證型形推導治則治法。核心紀律是「證→法推導鏈」——每一條治法都必須能回指證型的具體證候，禁止「經驗性堆砌治法」。

S4 提示詞模板

【角色】你是「治則確立法官」，負責由證立法。

【任務】依證型形實例執行：

1. 標本緩急：判定標證本證，確定「急則治標、緩則治本、標本兼治」策略。

2. 扶正祛邪：判定正邪盛衰，確定祛邪為主、扶正為主或攻補兼施。

3. 八法選定：汗吐下和溫清消補，選定主法與輔法，逐一說明對應證候。

4. 三因制宜：因人（體質形、年齡性別）、因時（季節病程）、因地制宜的修正。

5. 兼證夾雜的立法加減安排。

【輸出】治則治法表[治則｜治法｜對應證候（證→法推導鏈）｜時機｜修正因素]。

【鐵律】① 無推導鏈的治法不得出現；② 汗法須明確禁忌（瘡家衄家汗家禁汗）；③ 下法須評估正氣耐受；④ 緩急次序明確到先後時間。

∩(T) 檢核項	通過標準
證法對應	每條治法可回指證型的具體證候
標本有序	緩急次序明確且與病勢相符
禁忌反檢	所選治法的禁忌證逐一反向檢核通過
體質修正	體質形、時令、地域修正已納入

◆ 範例演練（續 S3 案）

S4 範例輸出

標本：標證 = 表寒實；本證 = 衛陽被遏。急則治標。

扶正祛邪：邪盛正未衰 → 祛邪為主。

治法：①辛溫解表（主法）——對應惡寒重、無汗、脈浮緊；②宣肺止咳（輔法）——對應咳嗽痰白清稀。

三因制宜：深秋淋雨感寒，加溫覆取汗之助；患者體壯能耐汗法。

禁忌反檢：無衄血、瘡家、汗家史，汗法可用；囑「微似有汗」不可大汗淋漓。

6.5 S5 方藥設計官 — 君臣佐使



【圖】S5 方藥設計官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S5 是安全閘門最密集的工作流：由治法進入處方，優先方證對應選用成方，以君臣佐使檢核組方結構，並以配伍禁忌（十八反、十九畏、妊娠禁忌、毒性藥劑量）逐對掃描。

S5 提示詞模板

【角色】你是「方藥設計官」，負責立法處方與用藥安全檢核。

【任務】依治則治法表執行：

1. 方證對應：優先選用成方（經方優先、時方次之），說明方源與條文依據；不用成方者須說明理由。

2. 君臣佐使：逐味標注角色——君藥直指主證、臣藥輔君、佐藥佐助佐制反佐、使藥引經調和。

3. 劑量與用法：每味藥給出常用量區間與本案取值理由；先煎後下包煎烊化另煎單列。

4. 安全檢核（紅線）：十八反十九畏逐對掃描、妊娠禁忌（孕產通道強制啟用）、毒性藥（附子烏頭馬錢子等）劑量與炮製、老人小兒劑量折算。

5. 加減備案：兼證或複診轉歸時的加減規則。

【輸出】處方 BOM 表[藥味｜角色｜劑量｜性味歸經｜治法指歸｜特殊煎法] + 煎服法 + 加減備案 + 方源依據。

【鐵律】① 禁忌命中立即停止並出紅燈報告；② 無治法指歸的藥味不得入方；③ 終審權在執業中醫師。

∩(T) 檢核項	通過標準	攔截級別
配伍禁忌	十八反十九畏零命中（或醫師書面例外）	紅燈：立即停止
妊娠禁忌	孕產通道下禁用藥零命中	紅燈
劑量邊界	每味藥在藥典常用量內；毒性藥有炮製與先煎	紅燈（超量）/ 黃燈（接近上限）
組方結構	君臣佐使齊備，君藥直指主證	黃燈：提示補正
方源依據	成方標注方源；自組方說明不用成方之由	黃燈

◆ 範例演練（續 S4 案）

S5 範例輸出（節錄）

選方：麻黃湯（《傷寒論》太陽傷寒提綱證）——方證對應：無汗、惡寒、脈浮緊、喘咳。

處方 BOM：君｜麻黃 9g｜辛溫微苦入肺膀胱｜發汗解表宣肺平喘｜先煎去沫；臣｜桂枝 6g｜辛甘溫｜解肌發表助麻黃發汗；佐｜杏仁 9g｜苦溫｜降氣止咳平喘；使｜甘草 3g｜甘平｜調和諸藥。

煎服法：水煎溫服，服後溫覆取微汗，啜熱稀粥一盞助汗；忌大汗。

安全檢核：十八反十九畏掃描零命中；非妊娠；麻黃含麻黃鹼，甲亢心悸失眠者慎用（本案無）。

加減備案：項背強几几加葛根 12g；咳嗽痰多加半夏 9g；裡熱加石膏 15g（麻杏石甘湯意）。

6.6 S6 針灸外治官 — 經穴處方



【圖】S6 針灸外治官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S6 依證型與病位制定針灸外治方案：循經取穴、局部取穴、特定穴配伍三路並行，主配穴分層，補瀉手法與留針時間明確，刺灸禁忌強制檢核。

S6 提示詞模板

【角色】你是「針灸外治官」，負責經穴處方與外治方案。

【任務】依證型形、病位與經絡辨證執行：

1. 取穴三路：循經取穴（病位所屬經脈）、局部取穴（阿是穴與鄰近穴）、特定穴配伍（五輸穴/原穴/俞募穴/八脈交會穴/下合穴）。

2. 主配穴分層：主穴 2–4 個直指主證，配穴依兼證加減。

3. 手法與劑量：補瀉手法（提插捻轉迎隨）依虛實而施；留針 15–30 分鐘；療程（隔日一次或每週三次）。

4. 擇時選項：子午流注依病位經脈當令時辰。

5. 禁忌檢核（紅線）：孕婦腰骶與合谷三陰交等禁刺穴、小兒囟門、出血傾向、飢飽疲勞醉酒、重要臟器部位刺法深度。

【輸出】穴位處方表[穴名｜歸經｜定位｜角色（主/配）｜補瀉｜刺法深度留針｜治法指歸]＋外治備案（艾灸拔罐推拿）。

【鐵律】① 禁刺禁灸部位命中立即停止；② 每穴須有經絡依據；③ 補瀉與證之虛實方向一致。

∩(T) 檢核項	通過標準
取穴有據	每穴標注歸經與治法指歸
補瀉合證	手法方向與虛實判定一致
禁忌通過	孕禁、部位、狀態禁忌掃描零命中
處方可操作	定位、深度、留針、療程完整可執行

◆ 範例演練（續 S5 案）

S6 範例輸出

處方：主穴｜大椎（督脈，諸陽之會，散寒解表，刺 0.5–0.8 寸，瀉法）｜風門（膀胱經，風邪出入之門，瀉法）｜列缺（肺經絡穴，頭項尋列缺，瀉法）。

配穴｜合谷（原穴，面口合谷收，加強解表）｜肺俞（背俞穴，宣肺止咳）。

外治備案：大椎風門拔罐 10 分鐘（風寒表實適宜）。

療程：每日一次，汗出症減後停針，改調理。

禁忌檢核：非妊娠、無出血傾向、無過勞過飢——通過。子午流注參考：膀胱經申時（15–17 時）取膀胱經穴效佳。

6.7 S7 療效演化官 — 病程評估



【圖】S7 療效演化官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S7 在複診時啟用：對比前後四診屬性變化，評估療效分級，判斷證型轉歸，輸出方案調整建議。

S7 同時承擔危急警訊掃描——任何惡化徵象（神昏、胸痛、大出血、呼吸困難）必須第一時間升級轉診。

S7 提示詞模板

【角色】你是「療效演化官」，負責前後對照、轉歸判斷與危急警訊掃描。

【任務】依初診病案形與複診四診執行：

1. 屬性對照：逐項對比初診與複診的症狀形/舌形/脈形屬性值變化（好轉/未變/加重/新增）。

2. 療效分級：顯效（主證消失≥70%）/ 有效（主證減輕 30–70%）/ 未效（＜30%）/ 加重。

3. 轉歸判斷：證型是否變化（如表證入裡、由實轉虛、熱化寒化），附時間證據與舌脈推移。

4. 方案調整：效不更方、隨證加減或改弦更張，說明理由與調整幅度。

5. 危急警訊掃描（紅線）：神志改變、胸痛徹背、大出血、呼吸困難、高熱驚厥、劇烈腹痛——命中即轉診。

【輸出】療效評估表[屬性｜初診值｜複診值｜變化｜時間節點] + 轉歸判斷 + 調整方案 + 警訊掃描報告。

【鐵律】① 無前後對照不下療效結論；② 轉歸必附舌脈推移證據；③ 警訊命中立即停止流程。

∩(T) 檢核項	通過標準
對照可量化	逐屬性前後對照，變化方向明確
轉歸有據	證型變化附時間證據與舌脈推移
調整合理	調整幅度與轉歸程度相符，效不更方原則被尊重
警訊掃描	危急症清單逐項過目並留痕

6.8 S8 知識沉澱官 — 醫案演化



【圖】S8 知識沉澱官：輸入→提示詞→判準→輸出工作流卡

S8 把一次診療閉環為可累積的知識：醫案結構化入庫、診療規律萃取、判準精進提案。S8 是時間本形「自我演化」的工作流化——但一切演化皆以提案形式產出，經醫師審核閘門後才生效。

S8 提示詞模板

【角色】你是「知識沉澱官」，負責醫案入庫與演化提案。

【任務】依完整病案形與療效結局執行：

1. 醫案規範化：主訴、現病史、四診、辨證鏈（S2–S4 產物）、治法方藥（S5–S6）、療效（S7）、時間軸節點——七段齊備。

2. 規律萃取：可一般化的診療規律（如「本案加葛根後項背強痛緩解迅速」），標注證據強度（單案/多案/經典支持）。

3. 判準精進提案：若療效與 ∩(T) 預測有系統性偏差，提出權重調整或鑑別要點補充提案。

4. 異常標注：與經典相悖、療效異常、診斷存疑的案例標注「待審」。

【輸出】病案形入庫檔 + 規律萃取報告 + 演化提案（默認不生效，待審）。

【鐵律】① 個案經驗與普遍規律嚴格區分標示；② 提案一律「不生效」直到審核通過；③ 病案含患者識別資訊者去識別化後入庫。

6.9　綜合醫案演練：一案走完 S1–S8

以下以一則完整醫案走讀全流程，展示八個工作流的實際銜接。案：王某，女，45 歲，失眠多夢三月，加重一週。



【圖】綜合醫案時間軸：初診→S1–S6→複診→S7–S8 閉環

工作流	本案輸出（節錄）	檢核結果	醫師覆核
S1	失眠多夢｜心悸健忘｜食少納呆｜面色萎黃｜神疲乏力｜月經量少色淡；舌淡苔薄白；脈細弱	缺口：聞診未採	補採後通過
S2	裡證｜虛證（氣血兩虛）｜寒象不顯｜陰證	每綱證據齊備	通過
S3	臟腑辨證：候選一 心脾兩虛證 ∩(T)=0.91；候選二 心腎不交 ∩(T)=0.48（排除：無煩熱腰酸）	≥2 候選、可覆算	通過
S4	標本兼治（病久本虛）；補益心脾、養血安神；歸脾湯意	證→法鏈完整	通過
S5	歸脾湯加減：君黃芪人參；臣當歸龍眼肉；佐白朮茯苓酸棗仁遠志；使甘草生薑大棗。禁忌掃描零命中	紅線零命中	通過簽署
S6	主穴神門三陰交足三里；配穴心俞脾俞百會；補法，隔日一次	禁忌通過	通過
S7（兩週後）	睡眠好轉（易醒減）、心悸減、食欲增；脈細較前有力；評定「有效」；效不更方加柏子仁	前後對照完整	通過
S8	醫案七段入庫；規律：「歸脾湯加夜交藤 30g 對入睡困難型心脾兩虛效佳」標注「單案經驗」；判準提案：食少納呆權重由 2 調至 2.5（待審）	提案不生效待審	審核中

◆ 演練重點解說

此案演示了三個關鍵操作。其一「多候選的價值」：S3 若只看「失眠」直奔心腎不交，便會漏掉「食少納呆、面色萎黃」指向的脾虛線索——強制多候選讓辨證從「找證據支持第一直覺」變成「證據與證型的雙向篩選」。其二「效不更方的節制」：S7 面對「有效但未癒」的中間狀態，沒有急於改弦更張，只作最小加減（加柏子仁安神），這是《傷寒論》「觀其脈證」的時間智慧。其三「演化的保守」：S8 的判準提案標注「待審」，單案經驗標注「單案」——知識沉澱的同時守住強度標示的紀律。

環節	本案關鍵決策	若反向操作的風險
S3 多候選	心脾兩虛為主、心腎不交列次選並排除	直覺式單證型易漏脾虛線索，歸脾湯改黃連阿膠湯則失治
S5 方證對應	以歸脾湯成方為骨架加減	自由組方（十味藥雜湊）使君臣無主、療效不可解釋
S7 效不更方	兩週有效只作最小加減	頻繁更方使藥效累積中斷，轉歸無法歸因
S8 強度標示	規律標「單案」、提案標「待審」	個案經驗直接入判準會污染未來辨證

6.10 提示詞使用要點與常見偏差

彙整實務上最常影響準確度的使用偏差與對策，作為手冊的日常檢核鏡：

常見偏差	典型表現	後果	對策
跳步直達	一則提示詞同時要求辨證＋開方	檢核鏈斷裂、幻覺率升高	嚴格 S1→S8 逐步交付
採集官越權	S1 輸出混入證型詞彙	暗示性偏見污染證據層	見證型詞彙即退回重做
單候選思維	S3 只列一個證型	鑑別診斷缺位、誤辨風險	強制 ≥ 2 候選＋反證檢查
自由文本交接	以散文摘要代替形實例傳遞	下游輸入失真	形規格表為唯一交接格式
禁忌後補	先開方再檢查禁忌	紅線形同虛設	S5 內建先掃描後出方
療效印象化	「睡得好些了」不作對照	轉歸判斷失據	S7 強制屬性級前後對照
忽視灰區	∩(T) 0.7 仍強出結論	把疑似判成確證	灰區並列證型＋建議補檢
不記錄版本	未記判準與提示詞版本	結果不可複現	會話結束記錄版本號

準確度來自流程，不來自運氣

以上八類偏差的共同根源，是把系統當「答案機」而非「受檢核的推理流程」。只要嚴守逐步交付、形化輸出、顯式缺口、版本記錄、紅線攔截五項總則，S1–S8 的組合準確度就會顯著高於單次直覺式提問。

6.11 第二演練：風熱咳嗽案的雙工作流對話實錄

本節以「逐字實錄」方式呈現 S1 與 S5 兩個工作流的實際對話樣貌，讓使用者直觀掌握提示詞的貼用方式、輸出的形化格式與檢核的發生時點。案：李某，男，28 歲，咳嗽三天，加重一天。

對話實錄一：S1 會話（貼用 S1 模板後）

使用者：（貼用 S1 模板）【輸入】主訴：咳嗽三天加重一天。現病史：三天前感冒後咳嗽，痰少而黏，色黃，咽喉腫痛，口微渴，發熱（T 38.2℃），汗出，頭痛。望診：面色微紅，咽部充血，舌尖紅苔薄黃。脈象：浮數。

系統：S1 四診採集表

症狀形：①咳嗽｜肺系｜乾咳少痰｜中度｜三天（加重一天）｜遇煙塵加重｜現病史；②痰｜肺系｜黏稠色黃｜少｜三天｜—｜現病史；③咽喉痛｜咽部｜紅腫痛｜中度｜三天｜吞嚥明顯｜現病史；④發熱｜全身｜T38.2℃｜中度｜三天｜—｜現病史；⑤汗出｜全身｜微汗｜輕度｜三天｜—｜現病史；⑥頭痛｜頭部｜脹痛｜輕度｜三天｜—｜現病史；⑦口渴｜口｜微渴喜冷飲｜輕度｜三天｜—｜現病史。

舌形：舌尖紅｜薄｜—｜黃｜薄｜未採集（舌下絡脈）。脈形：浮（位）｜數（數）｜—（形）｜有力（勢）｜齊（節律）｜分候未採集。

缺口清單：聞診（咳嗽聲響）、二便、舊病、用藥史未採集。

對話實錄二：S5 會話（承 S4 產物「辛涼解表、宣肺止咳」）

使用者：（貼用 S5 模板）【輸入】治法：辛涼解表、清肺止咳。證型：風熱犯肺（S3 產出 ∩(T)=0.89）。體質：平和質。非妊娠。

系統：S5 處方報告

【選方】桑菊飲（《溫病條辨》）——方證對應：咳嗽為主、身熱不甚、口微渴、苔薄黃脈浮數，屬風溫初起邪在肺絡。

【處方 BOM】君｜桑葉 9g｜甘苦寒｜疏風清熱宣肺止咳。臣｜菊花 9g｜辛甘苦微寒｜疏散風熱；杏仁 6g｜苦微溫｜降氣止咳。佐｜桔梗 6g｜苦辛平｜宣肺利咽（與杏仁一宣一降）；連翹 9g｜苦微寒｜清熱解毒；薄荷 3g（後下）｜辛涼｜疏散風熱利咽。使｜蘆根 15g｜甘寒｜清熱生津；甘草 3g｜甘平｜調和諸藥。

【煎服法】水煎溫服，日一劑分兩次；薄荷後下；服藥避風。

【安全檢核】十八反十九畏掃描：零命中｜妊娠禁忌：不適用｜劑量：全在常規區間｜配伍：無相惡相反。

【加減備案】痰黃黏加瓜蔞皮 9g、浙貝母 9g；咽痛甚加牛蒡子 6g、板藍根 12g；高熱加石膏 24g（麻杏石甘湯意）。

【覆核提示】本處方為 AI 輔助生成，須執業中醫師審核簽署後使用。

兩段實錄示範了三個要領：其一，S1 輸出中「未採集」明確列缺口，而非編造；其二，S5 的選方給出方源條文、BOM 逐味標注治法指歸、安全檢核逐項列示；其三，覆核提示自帶——這是系統出方的標準結尾，任何缺少覆核提示的 S5 輸出都應視為異常。

實錄觀察	體現的準確使用原則	若違反的後果
S1 只記錄不判斷	採集與辨證分權	暗示性偏見污染證據層
缺口清單顯式	缺失不補白	幻覺體徵進入 ∩(T) 計算
S5 選方給方源	結論必附證據	自由組方不可解釋
加減備案單列	決策與備援分離	複診調整失去依據
覆核提示自動附加	人機邊界內建	越權處方的法律與醫療風險

第 7 章　準確性保證與醫療安全

醫療輔助系統的價值 = 準確度 × 安全度。本章把四層準確性保證落到可執行的規範，並建立醫療安全護欄：用藥安全、危急警訊、不確定性管理與人工覆核，確保系統永遠站在「輔助」的位置上。

7.1　四層準確性保證的執行規範



【圖】四層準確性保證：逐層收斂不確定性

層	保證機制	執行規範	失敗處置
第一層	交集判準 ∩(T)	證型確立前必算吻合度；＜0.85 進入灰區流程並列證型	退 S3 重辨；禁止弱吻合出方
第二層	演繹骨架推理	證→法→方→藥每環可回指；Mind Model 推演鏈完整呈現	斷鏈環節標紅重推
第三層	臨床驗證覆核	執業中醫師覆核簽署；經典原文比對；文獻一致性檢查	未覆核不得採用
第四層	形證據鏈留痕	輸入輸出判準版本全程封存；醫案可重放複現	鏈節缺失即該步作廢

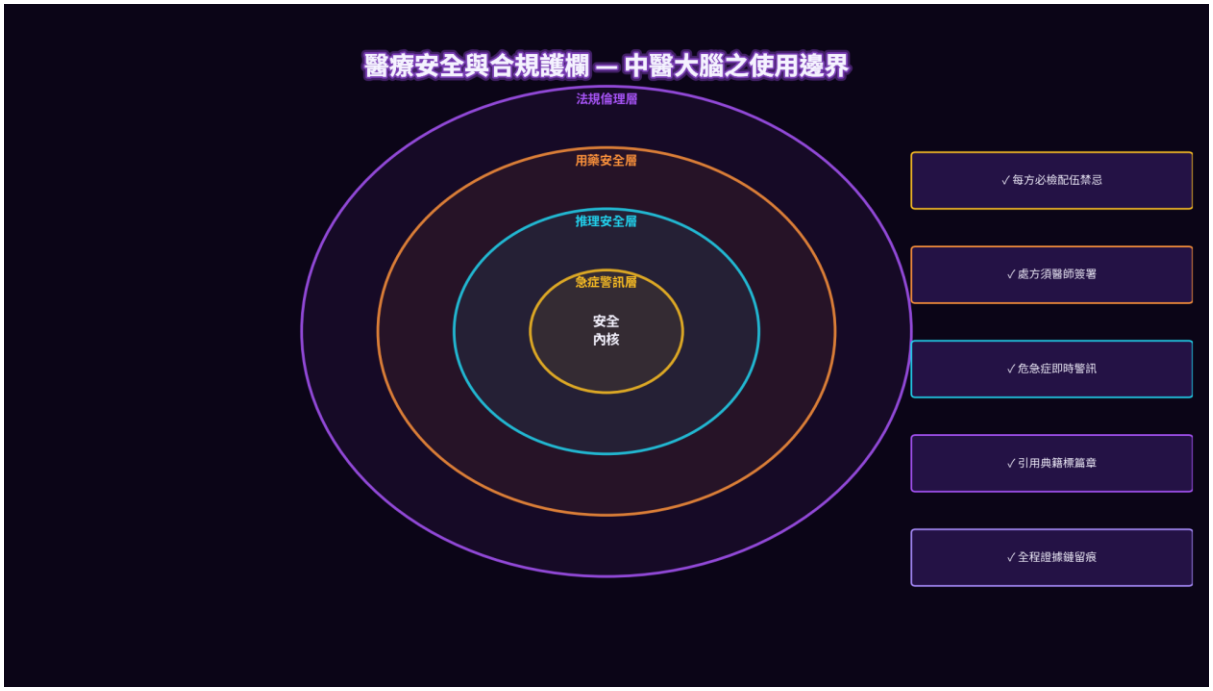
四層的運作哲學是「逐層收斂」：第一層收斂證型的不確定性，第二層收斂推理的跳躍性，第三層收斂機器的盲區，第四層收斂流程的不可追溯性。任何一層亮紅燈，都觸發「停止出方—標注不確定性—升級人工」的標準動作，而非繞過繼續。

7.2 形證據鏈與可審計性

形證據鏈的結構為：醫案頭（去識別化識別碼、時間、醫師）→ 四診快照鏈 → 推理鏈（八綱、辨證、∩(T) 計算書）→ 決策鏈（治法、處方 BOM、針灸方案、禁忌掃描報告）→ 結局鏈（療效對照、轉歸、演化提案）→ 審核簽名鏈。每個鏈節皆帶時間戳記與版本號。

審計場景	檢視內容	鏈中對應
醫療爭議回溯	當時為何如此辨證用藥	推理鏈 + 決策鏈逐環重放
合規檢查	處方審核、禁忌檢核是否執行	禁忌掃描報告 + 醫師簽名鏈
療效研究	同證型治療結局統計	結局鏈批式萃取（去識別化）
系統複現	同案同版本判準能否重放	判準版本號 + 提示詞版本號

7.3 醫療安全護欄



【圖】醫療安全與合規護欄：四環同心防護

- 法規倫理層：AI 輔助不處方——一切診療結論須執業中醫師審核簽署；患者資料去識別化、最小必要存取；使用同意與告知義務由醫療機構承擔；
- 用藥安全層：十八反十九畏強制掃描、妊娠禁忌分級攔截、毒性藥專帳管理（炮製、劑量、先煎）、老人小兒劑量折算；
- 推理安全層：幻覺防範三招——引文必溯源、結論必附證據、不確定必標注；經典原文引用須逐字核對篇章；
- 急症警訊層：危急重症識別即時警訊，第一優先轉診，不得以系統建議延誤救治。

7.4 用藥安全檢核清單

檢核項	內容	處置
十八反	烏頭反半夏瓜蔞貝母白及白蘞；甘草反海藻大戟甘遂芫花；藜蘆反諸參辛芍	命中即紅燈攔截

檢核項	內容	處置
十九畏	硫磺畏朴硝、水銀畏砒霜、狼毒畏密陀僧、巴豆畏牽牛、丁香畏鬱金、牙硝畏三稜、川烏草烏畏犀角、人參畏五靈脂、官桂畏赤石脂	命中即紅燈攔截
妊娠禁忌	禁用：芫花甘遂大戟巴豆牽牛水蛭虻蟲麝香三稜莪朮…；慎用：桃仁紅大黃枳實附子肉桂冬葵子…	孕產通道強制啟用
毒性藥管理	附子烏頭馬錢子朱砂雄黃細辛蒼耳子：炮製合規、劑量邊界、先煎久煎、蓄積監測	超量或炮製不明即攔截
特殊人群	老人（劑量 3/4 起）、小兒（按體重年齡折算）、肝腎功能不全（減量避毒）	自動折算並標注
中西藥交互	抗凝藥與活血藥、降壓藥與溫裡藥、鎮靜藥與安神藥同用時提示交互風險	黃燈提示醫師評估

7.5 危急重症識別與轉診警訊

系統內建危急警訊清單：命中任一項，S7 之類評估流程立即中止，彈出轉診指引。這是「急則治標」的現代化——先救命，再辨證。

警訊	表現	可能危候	即時處置
神志改變	神昏譫語、抽搐、口開目合、撒手遺尿	中風、熱入心包、脫證	立即急救轉診（120/急診）
胸痛徹背	胸悶痛連背、冷汗、唇紫	胸痹心真心痛（急性心梗）	立即急救轉診
呼吸困難	喘促鼻煽、張口抬肩、不能平臥	喘脫、肺閉	立即急救轉診
大出血	吐血便血崩漏不止、面色蒼白	血脫、亡陽	止血同時立即轉診
高熱驚厥	壯熱不退、小兒高熱抽風	急驚風、疫毒痢	退熱防驚同時轉診
劇烈腹痛	腹痛拒按、板狀腹、汗出肢冷	急腹症（腸結、石淋嵌頓）	禁食禁痛，立即轉診

7.6 不確定性管理與人工覆核

系統對不確定性採「顯式三級標注」：高置信（$\cap(T) \geq 0.85$ 且四診完備）標注為結論；中置信（灰區）並列證型與鑑別要點；低置信（$\cap(T) < 0.7$ 或關鍵四診缺失）只給檢查建議、不給結論。凡涉及毒性藥、孕產、兒科、急症、手術後等高風險情境，無論置信度高低，一律強制人工覆核。

置信級	條件	系統輸出形態	人工介入要求
高置信	$\cap(T) \geq 0.85$ 且四診完備	結論 + 證據鏈	常規覆核簽署
中置信	$0.70 \leq \cap(T) < 0.85$	並列證型 + 鑑別要點 + 補檢建議	醫師主導裁決
低置信	$\cap(T) < 0.70$ 或關鍵缺口	只給檢查建議與缺口清單	醫師接手主導
高風險	毒藥/孕產/兒科/急症/術後	任何置信級皆附紅框警示	強制覆核，不可單獨採用

> **系統永遠站在輔助位**
>
> 最終診療決定權、處方權、簽署權永遠在執業中醫師。系統的責任是：把不確定性說清楚、把證據擺完整、把紅線看牢——然後把決定交還給人。

7.7 醫療文書、倫理與個資規範

AI 產出的病歷文書屬醫療文書範疇，須符合病歷書寫規範與個資保護要求。系統在文書與資料層面的規範如下：

面向	規範	系統落實	責任歸屬
病歷書寫	客觀、真實、準確、及時、完整、規範	S1–S8 產物自動組裝病歷草稿；醫師修改留痕後簽署	簽署醫師負責
AI 標識	AI 參與生成之內容須可識別	文書尾欄標注「本病歷由 AI 中醫大腦輔助生成」	醫療機構負責

面向	規範	系統落實	責任歸屬
個資保護	去識別化、最小必要、目的限定	醫案入庫前去識別化；存取權限分級；傳輸加密	機構資訊安全責任
知情同意	告知 AI 輔助之使用與邊界	就診告知書範本內建 AI 輔助條款	醫療機構負責
資料保存	病歷保存年限依法規；形證據鏈同步保存	鏈式存證與病歷同週期保存	機構負責
研究使用	二次利用須去識別化並經倫理審查	醫案萃取僅供假設生成；研究輸出標注審查需求	研究者負責

7.8 中西醫結合使用注意事項

- 檢查互參：現代檢查（影像、實驗室）作為中醫四診的延伸資訊接入，標注為「客觀檢查」屬性，不替代舌脈；
- 病名互參：西醫病名與中醫病證並行記錄（如「冠心病 ↔ 胸痹」），但辨證推理一律以中醫證型形為主線；
- 用藥交互：中西藥併用時啟用交互提示層（抗凝藥與活血藥、降壓藥與溫裡藥、降糖藥與消渴方），並建議錯開服藥時間；
- 療效評價：雙軌記錄——中醫證候積分（主觀量表）與西醫指標（客觀數據）並行納入 S7 對照表；
- 急重症定位：明確「先西醫搶救、後中醫調理」的優先序，與第 7.5 節危急警訊體系接軌。

第 8 章　附錄

本章彙整速查工具：形名詞對照、方劑速查、本草速查、穴位速查、診療歌訣與提示詞總表，供臨床與教學即查即用。

8.1　附錄 A：中醫形名詞對照表

中文	English（Type 譯名）	一句定義
形	Type	有明確邊界的知識單元；全系統基本構件
症狀形	SymptomType	可觀察可察覺的異常表現之結構化
舌形	TongueType	舌象之結構化描述
脈形	PulseType	脈象之結構化描述
證型形	SyndromeType	病位病性病因病勢之綜合判斷模型
病因形	EtiologyType	致病因素之分類模型
臟腑形	ZangFuType	藏象功能模型
經絡形	MeridianType	經脈流注與絡屬模型
氣血津液形	QiType	氣血津液生成輸布病變模型
體質形	ConstitutionType	個體體質特徵模型
治則形	PrincipleType	治療總體策略模型
治法形	MethodType	具體治療方法模型
方劑形	FormulaType	處方組成模型（BOM）
本草形	HerbType	單味藥性用模型
穴位形	AcupointType	腧穴定位主治模型
病案形	CaseType	一次完整診療的時間膠囊
典籍形	ClassicType	文獻知識出處錨點
養生形	RegimenType	治未病方案模型

中文	English（Type 譯名）	一句定義
交集判準	∩(T) Criteria	證候集與證型判準集之量化吻合閘門
形證據鏈	Type Evidence Chain	全程留痕的推理存證鏈
形驅動辨證論治	Type-Driven Diagnosis & Treatment (TDDT)	八步驟臨床推理方法論
BOM / SOM	Bill of Materials / Set of Members	方劑藥味清單 / 證候同現集合

8.2 附錄 B：常用方劑速查表

分類	方名	組成（節錄）	功效	主治
解表	桂枝湯	桂枝芍藥生薑大棗甘草	解肌發表調和營衛	太陽中風表虛
解表	麻黃湯	麻黃桂枝杏仁甘草	發汗解表宣肺平喘	太陽傷寒表實
解表	九味羌活湯	羌活防風蒼朮細辛川芎白芷	發汗祛濕兼清裡熱	外感風寒濕兼裡熱
解表	小青龍湯	麻黃桂枝乾薑細辛半夏五味子	解表散寒溫肺化飲	外寒裡飲證
解表	銀翹散	金銀花連翹桔梗薄荷竹葉荊芥	辛涼透表清熱解毒	溫病初起
解表	麻杏石甘湯	麻黃杏仁石膏甘草	辛涼宣洩清肺平喘	肺熱壅盛咳喘
瀉下	大承氣湯	大黃芒硝枳實厚朴	峻下熱結	陽明腑實
瀉下	麻子仁丸	麻子仁杏仁芍藥枳實大黃厚朴	潤腸洩熱行氣通便	腸胃燥熱便秘
和解	小柴胡湯	柴胡黃芩半夏人參甘草	和解少陽	少陽病
和解	逍遙散	柴胡當歸白芍白朮茯苓薄荷	疏肝解鬱健脾養血	肝鬱血虛脾弱
和解	半夏瀉心湯	半夏黃芩黃連乾薑人參甘草	寒熱平調消痞散結	寒熱錯雜痞證
清熱	白虎湯	石膏知母粳米甘草	清氣分大熱	陽明經證
清熱	清營湯	犀角生地玄參麥冬黃連銀花連翹	清營解毒透熱養陰	熱入營分
清熱	犀角地黃湯	犀角生地芍藥丹皮	清熱解毒涼血散瘀	熱入血分
清熱	龍膽瀉肝湯	龍膽草黃芩梔子澤瀉車前柴胡	瀉肝膽實火清濕熱	肝火肝膽濕熱

分類	方名	組成（節錄）	功效	主治
清熱	青蒿鱉甲湯	青蒿鱉甲生地知母丹皮	養陰透熱	溫病後期陰虛邪伏
溫裡	理中丸	人參乾薑白朮甘草	溫中散寒健脾	脾胃虛寒太陰病
溫裡	小建中湯	桂枝芍藥飴糖生薑甘草	溫中補虛和裡緩急	虛勞裡急腹痛
溫裡	四逆湯	附子乾薑甘草	回陽救逆	少陰亡陽
溫裡	當歸四逆湯	當歸桂枝芍藥細辛通草	溫經散寒養血通脈	血虛寒厥
補益	四君子湯	人參白朮茯苓甘草	益氣健脾	脾胃氣虛
補益	參苓白朮散	人參白朮茯苓山藥蓮肉薏苡仁	益氣健脾滲濕止瀉	脾虛夾濕洩瀉
補益	補中益氣湯	黃芪人參白朮當歸升麻柴胡	補中益氣升陽舉陷	氣虛下陷、氣虛發熱
補益	四物湯	當歸川芎白芍熟地	補血調血	血虛血滯
補益	當歸補血湯	黃芪當歸（5:1）	補氣生血	血虛陽浮發熱
補益	六味地黃丸	熟地山萸肉山藥澤瀉茯苓丹皮	滋陰補腎	腎陰虛
補益	左歸丸	熟地山藥枸杞山萸菟絲鹿角膠	滋陰補腎填精益髓	真陰不足
補益	右歸丸	附子肉桂鹿角膠熟地山藥杜仲	溫補腎陽填精補血	腎陽不足命門火衰
補益	一貫煎	沙參麥冬當歸生地枸杞川楝子	滋陰疏肝	肝腎陰虛肝鬱
補益	歸脾湯	人參黃芪白朮當歸龍眼酸棗仁遠志	益氣補血健脾養心	心脾兩虛
理氣	越鞠丸	香附川芎蒼朮梔子神曲	行氣解鬱	六鬱證
理氣	半夏厚朴湯	半夏厚朴茯苓生薑蘇葉	行氣散結降逆化痰	梅核氣
理血	血府逐瘀湯	桃仁紅當歸川芎柴胡枳殼牛膝	活血化瘀行氣止痛	胸中血瘀
理血	補陽還五湯	黃芪當歸尾川芎赤芍地龍桃仁紅	補氣活血通絡	中風後遺氣虛血瘀
治風	川芎茶調散	川芎荊芥防風細辛白芷薄荷	疏風止痛	風邪頭痛
治風	天麻鉤藤飲	天麻鉤藤石決明梔子黃芩牛膝	平肝息風清熱活血	肝陽上亢眩暈
治燥	桑杏湯	桑葉杏仁沙參貝母梔子豆豉	清宣溫燥潤肺止咳	溫燥傷肺
治燥	百合固金湯	百合生地熟地麥冬貝母桔梗	滋陰潤肺化痰止咳	肺腎陰虛咳血
祛濕	平胃散	蒼朮厚朴陳皮甘草	燥濕運脾行氣和胃	濕滯脾胃

分類	方名	組成（節錄）	功效	主治
祛濕	藿香正氣散	藿香紫蘇白芷半夏厚朴陳皮	解表化濕理氣和中	外感風寒內傷濕滯
祛濕	茵陳蒿湯	茵陳梔子大黃	清熱利濕退黃	濕熱黃疸
祛濕	八正散	木通瞿麥萹蓄滑石車前梔子大黃	清熱瀉火利水通淋	濕熱淋證
祛濕	真武湯	附子白朮茯苓芍藥生薑	溫陽利水	陽虛水腫
祛濕	獨活寄生湯	獨活桑寄生杜仲牛膝細辛秦艽	祛風濕止痹痛補肝腎益氣血	痹證日久肝腎兩虛
祛痰	二陳湯	半夏陳皮茯苓甘草	燥濕化痰理氣和中	濕痰
祛痰	溫膽湯	半夏竹茹枳實陳皮茯苓	理氣化痰和胃利膽	膽鬱痰擾
消導	保和丸	山楂神曲萊菔子半夏陳皮茯苓	消食和胃	食積
安神	朱砂安神丸	朱砂黃連生地當歸甘草	鎮心安神養陰清熱	心火亢盛陰血不足
安神	天王補心丹	生地天冬麥冬酸棗仁柏子仁丹參	滋陰清熱養血安神	陰虛血少失眠
固澀	玉屏風散	黃芪白朮防風	益氣固表止汗	表虛自汗易感
固澀	四神丸	補骨脂肉豆蔻五味子吳茱萸	溫腎暖脾澀腸止瀉	五更洩瀉
開竅	安宮牛黃丸	牛黃麝香犀角鬱金黃連朱砂	清熱開竅豁痰解毒	熱入心包神昏
開竅	蘇合香丸	蘇合香麝香安息香丁香檀香	芳香開竅行氣止痛	寒閉神昏
解表	敗毒散	柴胡前胡川芎枳殼羌活獨活茯苓	散寒祛濕益氣解表	氣虛外感風寒濕
解表	再造散	黃芪人參桂枝附子細辛羌活	助陽益氣發汗解表	陽虛外感
和解	蒿芩清膽湯	青蒿黃芩竹茹半夏陳皮枳殼	清膽利濕和胃化痰	少陽濕熱痰濁
清熱	黃連解毒湯	黃連黃芩黃梔子	瀉火解毒	三焦火毒熱盛
清熱	普濟消毒飲	黃芩黃連牛蒡子薄荷連翹板藍根	清熱解毒疏風散邪	大頭瘟
清熱	導赤散	生地木通竹葉生甘草梢	清心利水養陰	心經火熱／口瘡
溫裡	吳茱萸湯	吳茱萸人參生薑大棗	溫中補虛降逆止嘔	肝寒犯胃／少陰吐利
溫裡	陽和湯	熟地鹿角膠肉桂麻黃白芥子	溫陽補血散寒通滯	陰疽貼骨疽
補益	生脈散	人參麥冬五味子	益氣生津斂陰止汗	氣陰兩虛／暑傷氣陰
補益	炙甘草湯	炙甘草人參桂枝生地麥冬阿膠	益氣滋陰通陽復脈	心動悸脈結代

分類	方名	組成（節錄）	功效	主治
補益	腎氣丸	附子肉桂六味地黃丸基礎	補腎助陽	腎陽不足
理氣	枳實薤白桂枝湯	枳實薤白桂枝厚朴瓜蔞	通陽散結祛痰下氣	胸痹心中痞滿
理血	小薊飲子	小薊生地滑石木通蒲黃藕節	涼血止血利水通淋	下焦瘀熱血淋
理血	桂枝茯苓丸	桂枝茯苓丹皮桃仁芍藥	活血化瘀緩消癥塊	瘀阻胞宮癥瘕
治燥	麥門冬湯	麥冬半夏人參甘草粳米	滋養肺胃降逆下氣	肺痿咳唾涎沫
祛濕	五苓散	豬苓澤瀉白朮茯苓桂枝	利水滲濕溫陽化氣	蓄水證水腫洩瀉
祛濕	苓桂朮甘湯	茯苓桂枝白朮甘草	溫陽化飲健脾利濕	中陽不足痰飲
消導	枳實導滯丸	枳實大黃黃芩黃連神曲白朮	消導化積清熱祛濕	濕熱食積
治風	大秦艽湯	秦艽羌活防風川芎當歸細辛	疏風清熱養血活血	風邪初中經絡
固澀	真人養臟湯	罌粟殼肉豆蔻訶子人參白朮	澀腸固脫溫補脾腎	久瀉久痢脾腎虛寒

8.3 附錄 C：常用本草速查表

藥名	性味	歸經	功效	要點
麻黃	辛微苦溫	肺膀胱	發汗解表宣肺平喘利水	表實無汗要藥；先煎去沫；汗多者忌
桂枝	辛甘溫	心肺膀胱	發汗解肌溫通經脈助陽化氣	表虛有汗亦可用（配白芍）
柴胡	苦辛微寒	肝膽	解表退熱疏肝解鬱升舉陽氣	少陽要藥；陰虛陽亢慎用
石膏	甘辛大寒	肺胃	清熱瀉火除煩止渴	氣分大熱要藥；脾胃虛寒忌
黃連	苦寒	心肝胃大腸	清熱燥濕瀉火解毒	中焦濕熱要藥；苦寒傷胃中病即止
金銀花	甘寒	肺心胃	清熱解毒疏散風熱	瘡瘍要藥；炒炭止痢
大黃	苦寒	脾胃大腸肝心包	瀉下攻積清熱瀉火涼血解毒	將軍之品；孕婦忌；生用後下

藥名	性味	歸經	功效	要點
附子	辛甘大熱	心腎脾	回陽救逆補火助陽散寒止痛	回陽第一品；須炮製先煎；陰虛忌
乾薑	辛熱	脾胃腎心肺	溫中散寒回陽通脈溫肺化飲	溫中要藥；與附子相須
人參	甘微苦微溫	肺脾心	大補元氣補脾益肺生津安神	救脫要藥；反藜蘆；實證忌
黃芪	甘微溫	脾肺	補氣升陽固表止汗利水消腫	補氣要藥；生用固表炙用補中
白朮	苦甘溫	脾胃	健脾益氣燥濕利水止汗安胎	脾虛要藥；炒用止瀉
當歸	甘辛溫	肝心脾	補血活血調經止痛潤腸	血中聖藥；便溏者慎
熟地黃	甘微溫	肝腎	補血養陰填精益髓	滋膩礙胃；宜配砂仁陳皮
白芍	苦酸微寒	肝脾	養血斂陰柔肝止痛平抑肝陽	與桂枝一散一收調營衛
川芎	辛溫	肝膽心包	活血行氣祛風止痛	血中氣藥；頭痛要藥；孕婦慎
丹參	苦微寒	心肝	活血祛瘀涼血消癰養血安神	一味丹參功同四物；反藜蘆
半夏	辛溫	脾胃肺	燥濕化痰降逆止嘔消痞散結	燥濕化痰要藥；反烏頭；生半夏有毒
茯苓	甘淡平	心肺脾腎	利水滲濕健脾寧心	利水不傷正；白茯苓偏補
甘草	甘平	心肺脾胃	補脾益氣清熱解毒祛痰止咳緩急止痛調和諸藥	國老之稱；反大戟甘遂芫花海藻；久服水腫
陳皮	辛苦溫	脾肺	理氣健脾燥濕化痰	氣滯痰濕要藥；配補藥防壅滯
香附	辛微苦微甘平	肝脾三焦	疏肝解鬱理氣寬中調經止痛	氣病總司；女科主帥
酸棗仁	甘酸平	肝膽心	養心補肝寧心安神斂汗生津	失眠要藥；生用炒用有別
天麻	甘平	肝	息風止痙平抑肝陽祛風通絡	眩暈要藥；不論虛實寒熱皆可配伍
三七	甘微苦溫	肝胃	散瘀止血消腫定痛	止血不留瘀化瘀不傷正
黃芪	甘微溫	脾肺	補氣升陽固表止汗利水托毒	補氣之長；生炙用法有別
柴胡	苦辛微寒	肝膽	和解退熱疏肝升陽	少陽要藥；劫肝陰之戒
葛根	甘辛涼	脾胃	解肌退熱生津止渴透疹升陽	項背強痛要藥；煨用止瀉

藥名	性味	歸經	功效	要點
金銀花	甘寒	肺心胃	清熱解毒疏散風熱	瘡瘍聖藥；炒炭止痢
黃芩	苦寒	肺膽脾胃大腸	清熱燥濕瀉火解毒止血安胎	上焦濕熱；安胎要藥
生地黃	甘苦寒	心肝腎	清熱涼血養陰生津	熱入營血；滋膩礙胃
麥冬	甘微苦微寒	肺胃心	養陰潤肺益胃生津清心除煩	肺胃陰虛要藥
枸杞子	甘平	肝腎	滋補肝腎益精明目	平補陰陽；明目要藥
杜仲	甘溫	肝腎	補肝腎強筋骨安胎	腰痛要藥；炒用效佳
丹皮	苦辛微寒	心肝腎	清熱涼血活血化瘀	涼血不留瘀；陰虛發熱
赤芍	苦微寒	肝	清熱涼血散瘀止痛	血熱瘀滯；反藜蘆
桔梗	苦辛平	肺	宣肺祛痰利咽排膿載藥上行	舟楫之劑；開提肺氣
杏仁	苦微溫	肺大腸	止咳平喘潤腸通便	降肺氣；有小毒勿過量
柴胡・黃芩	辛苦微寒	肝膽	和解少陽基本藥對	見藥對表
細辛	辛溫	心肺腎	祛風散寒通竅止痛溫肺化飲	頭痛要藥；細辛不過錢之戒
肉桂	辛甘大熱	腎脾心肝	補火助陽引火歸原散寒止痛溫經通脈	命門火衰；後下焗服
五味子	酸甘溫	肺心腎	收斂固澀益氣生津補腎寧心	久咳虛喘；斂汗安神

8.4 附錄 D：常用穴位速查表

穴位	歸經	定位	特定穴	主治要點
合谷	大腸經	手背第 1–2 掌骨間	原穴	面口合谷收；解表止痛通絡
曲池	大腸經	肘橫紋外側端	合穴	清熱疏風；上肢不遂皮膚病
足三里	胃經	犢鼻下 3 寸	合穴下合穴	肚腹三里留；健脾胃補虛弱
內關	心包經	腕橫紋上 2 寸	絡穴八脈交會	心胸內關謀；止嘔安神寬胸
神門	心經	腕橫紋尺側端	原穴輸穴	寧心安神；失眠心悸要穴

穴位	歸經	定位	特定穴	主治要點
三陰交	脾經	內踝尖上 3 寸	肝脾腎三經交會	婦科要穴；孕期禁針
太沖	肝經	足背第 1–2 蹠骨間	原穴輸穴	疏肝理氣；四關穴之一
太溪	腎經	內踝尖與跟腱間	原穴	補腎要穴；咽喉乾痛耳鳴
陽陵泉	膽經	腓骨小頭前下方	合穴八會（筋會）	脅痛口苦；筋病要穴
委中	膀胱經	膕橫紋中點	合穴	腰背委中求
大椎	督脈	第 7 頸椎棘突下	諸陽之會	解表退熱；截瘧要穴
百會	督脈	頭頂正中	諸陽之會	升陽舉陷；安神醒腦
中脘	任脈	臍上 4 寸	胃募八會（腑會）	胃腑一切病；和胃健脾
關元	任脈	臍下 3 寸	小腸募	溫補元氣；回陽固脫
氣海	任脈	臍下 1.5 寸	肓之原	補氣要穴；氣虛諸證
肺俞	膀胱經	第 3 胸椎旁開 1.5 寸	背俞穴	肺系病要穴；補肺固表
腎俞	膀胱經	第 2 腰椎旁開 1.5 寸	背俞穴	補腎強腰；耳鳴遺精
列缺	肺經	橈骨莖突上方	絡穴八脈交會	頭項尋列缺；宣肺止咳
中渚	三焦經	手背第 4–5 掌骨間	輸穴	少陽頭痛耳鳴；疏三焦氣
外關	三焦經	腕背橫紋上 2 寸	絡穴八脈交會	少陽病要穴；熱病頭痛
水溝（人中）	督脈	人中溝上 1/3	急救要穴	醒腦開竅；中暑昏厥
湧泉	腎經	足底前 1/3 凹陷	井穴	急救引火下行；頭痛眩暈
膈俞	膀胱經	第 7 胸椎旁開 1.5 寸	背俞穴八會（血會）	血證要穴；呃逆
天樞	胃經	臍旁 2 寸	大腸募穴	便秘洩瀉雙向調節
豐隆	胃經	外踝尖上 8 寸	絡穴	化痰要穴；痰多眩暈
太淵	肺經	腕橫紋橈側	原穴八會（脈會）	肺虛咳喘；脈病要穴
期門	肝經	乳頭直下第 6 肋間	肝募穴	疏肝理氣；胸脅脹痛
命門	督脈	第 2 腰椎棘突下	要穴	溫補腎陽；腰痛陽虛
至陰	膀胱經	足小趾外側	井穴	胎位不正艾灸要穴

子午流注十二時辰用藥・取穴速查

子時（23–01）膽經｜丑時（01–03）肝經｜寅時（03–05）肺經｜卯時（05–07）大腸經

辰時（07–09）胃經｜巳時（09–11）脾經｜午時（11–13）心經｜未時（13–15）小腸經

申時（15–17）膀胱經｜酉時（17–19）腎經｜戌時（19–21）心包經｜亥時（21–23）三焦經

運用：當令經脈之病於其時辰取穴效佳；補虛藥於臟腑當令前服；瀉實藥於病經當令時服。

8.5 附錄 E：診療歌訣摘編

十問歌（問診綱目）

一問寒熱二問汗，三問頭身四問便，五問飲食六問胸，七聾八渴俱當辨，

九問舊病十問因，再兼服藥參機變；婦女尤必問經期，遲速閉崩皆可見；

再添片語告兒科，天花麻疹全占驗。

藥性賦・四氣五味要義

四氣：寒涼治熱、溫熱治寒。

五味：辛散、酸收、甘緩、苦堅、鹹軟；辛甘發散為陽，酸苦湧洩為陰。

升降浮沉：升浮上行外達（升麻柴胡），沉降下行內收（大黃代赭石）。

歸經：引藥達所——羌活入膀胱治頭項，白芷入陽明治眉稜。

配伍：相須相使增效，相畏相殺減毒，相惡相反為忌。

脈綱提要

浮脈主表沉主裡，遲脈主寒數脈熱；虛脈主虛實脈實，滑脈痰食澀血瘀。

弦脈肝膽痛證見，緊脈寒痛宿食停；細脈氣血兩虛濕，代結促動各分明。

寸關尺分候：左寸心左關肝左尺腎；右寸肺右關脾右尺命門。

病機十九條（《素問・至真要大論》節錄）

諸風掉眩，皆屬於肝；諸寒收引，皆屬於腎；諸氣膹鬱，皆屬於肺；諸濕腫滿，皆屬於脾；

諸熱瞀瘈，皆屬於火；諸痛癢瘡，皆屬於心；諸厥固泄，皆屬於下；諸痿喘嘔，皆屬於上；

諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火；諸痙項強，皆屬於濕；諸逆衝上，皆屬於火；

諸脹腹大，皆屬於熱；諸躁狂越，皆屬於火；諸暴強直，皆屬於風；

諸病有聲，鼓之如鼓，皆屬於熱；諸病胕腫疼酸驚駭，皆屬於火；諸轉反戾，水液渾濁，皆屬於熱；

諸病水液，澄澈清冷，皆屬於寒；諸嘔吐酸，暴注下迫，皆屬於熱。

——十九條為病機推演之綱目，與臟腑形、病因形直接對應。

8.6 附錄 F：S1–S8 提示詞速查總表

工作流	一句定位	核心鐵律	關鍵輸出	紅線
S1 四診採集官	只記錄不判斷	未採集禁止補白	四診屬性表 + 缺口清單	見證型詞彙即退回
S2 八綱定位官	病位病性第一層	每綱必附證據	八綱定位表	不越權寫臟腑證型
S3 辨證推理官	多體系推演排名	強制 ≥ 2 候選	候選證型 + ∩(T)	六經溫病不混用
S4 治則確立法官	由證立法	無推導鏈不立法	治則治法表	汗下禁忌反檢
S5 方藥設計官	立法處方 + 安全掃描	無指歸不入方	處方 BOM + 煎服法	十八反十九畏妊禁
S6 針灸外治官	經穴處方	每穴須有經絡依據	穴位處方 + 療程	禁刺禁灸攔截
S7 療效演化官	前後對照 + 警訊掃描	無對照不下療效	療效評估 + 調整	危急警訊即轉診
S8 知識沉澱官	醫案閉環入庫	提案默認不生效	病案 + 演化提案	去識別化入庫

速查表與第 6 章詳版配合使用：日常按此表記憶鐵律與紅線，實作時回到第 6 章取完整提示詞模板與規格表。

8.7 附錄 G：核心術語英中對照索引

中文術語	English	應用位置
辨證論治	Syndrome Differentiation and Treatment	全書核心方法
四診	Four Examinations (Inspection/Auscultation-Olfaction/Inquiry/Palpation)	S1
八綱	Eight Principles	S2
證型	Syndrome Pattern	S3–S4
治則	Treatment Principle	S4
治法	Treatment Method	S4
君臣佐使	Monarch-Minister-Assistant-Guide	S5
方證對應	Formula-Pattern Correspondence	S5
歸經	Meridian Tropism	本草形
四氣五味	Four Qi and Five Flavors	本草形
升降浮沉	Ascending-Descending-Floating-Sinking	本草形
配伍七情	Seven Types of Compatibility	4.4
十八反十九畏	Eighteen Incompatibilities and Nineteen Antagonisms	S5 / 7.4
經絡	Meridians and Collaterals	S6
腧穴	Acupoints	S6
特定穴	Specific Points	4.6 / 附錄 D
子午流注	Midnight-Midday Ebb and Flow	3.4 / 附錄 D
補瀉手法	Reinforcing and Reducing Techniques	S6
治未病	Preventive Treatment of Disease	4.7

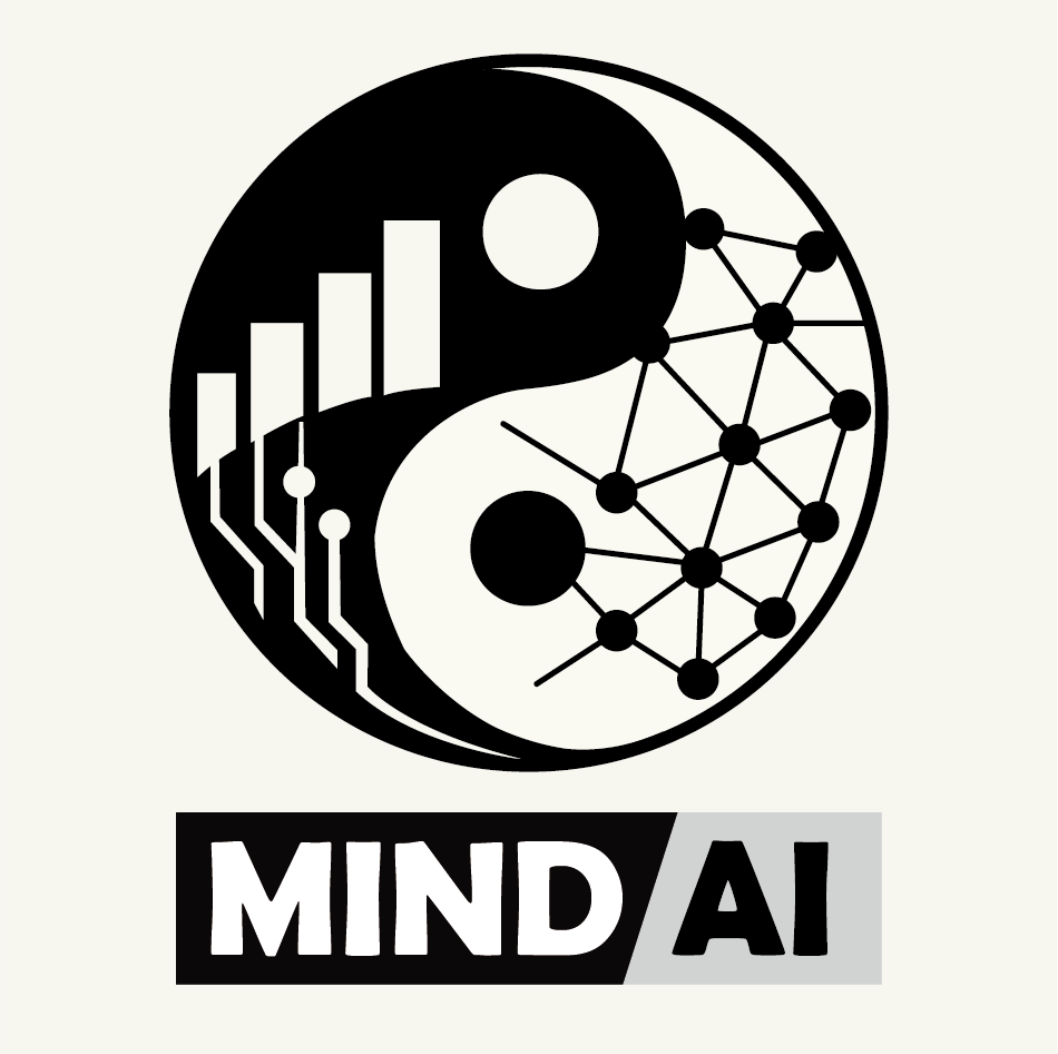
中文術語	English	應用位置
體質辨識	Constitution Identification	4.7
醫案	Medical Case Record	S8
傳變	Pathological Transmission	3.1–3.2
標本緩急	Root-Branch and Urgency	S4
三因制宜	Treatment in Accordance with Three Conditions	S4
形證據鏈	Type Evidence Chain	全書

8.8 附錄 H：常見病治法方藥總表

病證	證型	治法	代表方・要穴
感冒	風寒束表 / 風熱犯表 / 暑濕傷表 / 氣虛感冒	辛溫解表 / 辛涼解表 / 清暑祛濕解表 / 益氣解表	荊防敗毒散 / 銀翹散 / 新加香薷散 / 參蘇飲；大椎風門
咳嗽	風寒襲肺 / 風熱犯肺 / 燥邪傷肺 / 痰濕蘊肺 / 肝火犯肺 / 肺陰虧虛	疏風散寒宣肺 / 疏風清熱宣肺 / 疏風清肺潤燥 / 燥濕化痰 / 清肺瀉肝 / 滋陰潤肺	三拗湯 / 桑菊飲 / 桑杏湯 / 二陳湯 / 瀉白散 / 沙參麥冬湯；肺俞列缺
哮病	冷哮 / 熱哮 / 寒包熱哮 / 風痰哮 / 虛哮	宣肺散寒化痰 / 清熱宣肺化痰 / 解表清裡 / 祛風滌痰 / 補肺納腎	射干麻黃湯 / 定喘湯 / 小青龍加石膏湯 / 三子養親湯 / 平喘固本湯
心悸	心虛膽怯 / 心血不足 / 心陽不振 / 水飲凌心 / 心血瘀阻	鎮驚定志養心 / 補血養心益氣安神 / 溫補心陽 / 振奮心陽化氣利水 / 活血化瘀理氣通絡	安神定志丸 / 歸脾湯 / 桂甘龍牡湯 / 苓桂朮甘湯 / 桃仁紅花煎；神門內關
胸痹	心血瘀阻 / 氣滯心胸 / 痰濁閉阻 / 寒凝心脈 / 氣陰兩虛 / 心腎陰虛	活血化瘀通脈止痛 / 疏肝理氣活血 / 通陽洩濁豁痰 / 辛溫散寒通陽 / 益氣養陰活血通脈 / 滋陰清火養心和絡	血府逐瘀湯 / 柴胡疏肝散 / 栝蔞薤白半夏湯 / 枳實薤白桂枝湯 / 生脈散 / 天王補心丹；膻中巨闕

病證	證型	治法	代表方・要穴
不寐	肝火擾心 / 痰熱擾心 / 心脾兩虛 / 心腎不交 / 心膽氣虛	疏肝瀉火鎮心安神 / 清化痰熱和中安神 / 補益心脾養血安神 / 滋陰降火交通心腎 / 益氣鎮驚安神定志	龍膽瀉肝湯 / 黃連溫膽湯 / 歸脾湯 / 黃連阿膠湯 / 安神定志丸；神門三陰交
胃痛	寒邪客胃 / 飲食停滯 / 肝氣犯胃 / 肝胃鬱熱 / 瘀血停胃 / 胃陰虧虛 / 脾胃虛寒	散寒止痛 / 消食導滯 / 疏肝理氣 / 疏肝泄熱和胃 / 化瘀通絡 / 養陰益胃 / 溫中健脾	良附丸 / 保和丸 / 柴胡疏肝散 / 化肝煎 / 失笑散 / 一貫煎 / 黃芪建中湯；中脘足三里
泄瀉	寒濕內盛 / 濕熱傷中 / 食滯腸胃 / 脾胃虛弱 / 腎陽虛衰	芳香化濕解表散寒 / 清熱利濕 / 消食導滯 / 健脾益氣化濕 / 溫補脾腎固澀止瀉	藿香正氣散 / 葛根芩連湯 / 保和丸 / 參苓白朮散 / 四神丸；天樞神闕
便秘	熱祕 / 氣祕 / 冷祕 / 氣虛祕 / 血虛祕 / 陰虛祕 / 陽虛祕	瀉熱導滯潤腸通便 / 順氣導滯 / 溫裡散寒通便 / 益氣潤腸 / 養血潤燥 / 滋陰通便 / 溫陽通便	麻子仁丸 / 六磨湯 / 溫脾湯 / 黃芪湯 / 潤腸丸 / 增液湯 / 濟川煎；天樞大腸俞
眩暈	肝陽上亢 / 氣血虧虛 / 腎精不足 / 痰濕中阻	平肝潛陽滋養肝腎 / 補益氣血調養心脾 / 滋養肝腎益精填髓 / 化痰祛濕健脾和胃	天麻鉤藤飲 / 歸脾湯 / 左歸丸 / 半夏白朮天麻湯；風池百會
頭痛	風寒頭痛 / 風熱頭痛 / 風濕頭痛 / 肝陽頭痛 / 血虛頭痛 / 痰濁頭痛 / 腎虛頭痛 / 瘀血頭痛	疏風散寒 / 疏風清熱 / 祛風勝濕 / 平肝潛陽 / 養血滋陰 / 健脾燥濕化痰降逆 / 養陰補腎填精生髓 / 活血化瘀通竅	川芎茶調散 / 芎芷石膏湯 / 羌活勝濕湯 / 天麻鉤藤飲 / 加味四物湯 / 半夏白朮天麻湯 / 大補元煎 / 通竅活血湯；按六經分部取穴
中風（中經絡）	風痰入絡 / 風陽上擾 / 陰虛風動	祛風化痰通絡 / 平肝潛陽活血通絡 / 滋陰潛陽息風通絡	真方白丸子 / 天麻鉤藤飲 / 鎮肝息風湯；水溝內關三陰交
消渴	上消肺熱津傷 / 中消胃熱熾盛 / 下消腎陰虧虛 / 陰陽兩虛	清熱潤肺生津止渴 / 清胃瀉火養陰增液 / 滋陰固腎 / 滋陰溫陽補腎固攝	消渴方 / 玉女煎 / 六味地黃丸 / 金匱腎氣丸；肺俞脾俞腎俞

病證	證型	治法	代表方・要穴
痹證	行痹 / 痛痹 / 著痹 / 風濕熱痹 / 痰瘀痹阻 / 肝腎兩虛	祛風通絡散寒除濕 / 溫經散寒祛風除濕 / 除濕通絡祛風散寒 / 清熱通絡祛風除濕 / 化痰行瘀蠲痹通絡 / 培補肝腎舒筋止痛	防風湯 / 烏頭湯 / 薏苡仁湯 / 白虎加桂枝湯 / 雙合湯 / 獨活寄生湯；阿是穴局部取穴
水腫	風水相搏 / 濕毒浸淫 / 水濕浸漬 / 濕熱壅盛 / 脾陽虛衰 / 腎陽衰微	疏風清熱宣肺行水 / 宣肺解毒利濕消腫 / 運脾化濕通陽利水 / 分利濕熱 / 溫運脾陽以利水濕 / 溫腎助陽化氣行水	越婢加朮湯 / 麻黃連翹赤小豆湯 / 五皮飲 / 疏鑿飲子 / 實脾飲 / 真武湯；水分氣海
月經不調	肝鬱 / 血熱 / 血寒 / 血虛 / 氣虛 / 腎虛	疏肝理氣調經 / 清熱涼血調經 / 溫經散寒調經 / 補血益氣調經 / 補脾益氣攝血固沖 / 補腎調經	逍遙散 / 清經散 / 溫經湯 / 四物湯 / 補中益氣湯 / 歸腎丸；三陰交關元



www.longreat.net

張長豐 gamma@livemail.tw

張梼潁 mindaiworks@gmail.com